

PACIENTE TIPO

Minileyenda

- Lo **rojo** es muy **característico**.
- Lo **verde** es **patognomónico**.
- Lo **naranja** hace referencia a **lo + frecuente**.
- Lo **subrayado en amarillo** es **tratamiento**.

CARDIOLOGÍA

TEMA 4	INSUFICIENCIA CARDIACA
INTOXICACIÓN DIGITÁLICA	Anciano con antecedente personal de <u>insuficiencia renal</u> con IC + FA crónica que comienza con síntomas digestivos (náuseas, vómitos...), confusión y arritmias (+ frec: extrasístoles).
TEMA 5	MIOCARDIOPATÍAS.
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA	Joven con disnea de esfuerzo +/- dolor torácico +/- síncope que tiene un soplo sistólico en borde esternal izquierdo/foco aórtico que aumenta con valsava y un ECG con ondas Q en precordiales izquierdas e HVI . Pueden asociar FA.
ENFERMEDAD DE YAMAGUCHI	Miocardiopatía hipertrófica apical + ECG: ONDA T negativas gigantes precordiales y cateterismo en "as de pica" .
MIOCARDIOPATÍA DILATADA	JOVEN + RAZA NEGRA (+ agresivos) + disfunción sistólica .
- MCD DILATADA ALCOHÓLICA	Paciente con IC Sistólica + consumo crónico de alcohol <u>OJO: esta patología es REVERSIBLE</u>
- MCD DILATADA CHAGAS	Paciente de origen de América central/sur que lleva aprox. 15-20 años en nuestro medio y tiene un debut de IC sistólica . ECG: BRD + HBAI + BAV 1 grado. ANEURISMAS VENTRICULARES.
- MCD DILATADA PERIPARTO	Mujer en el <u>periparto</u> comienza con IC sistólica aguda y grave . Son mujeres obesas, preeclampsia, tto tocolítico o embarazo gemelar .

- MCD DILATADA POR FÁRMACOS	Paciente ONCOLÓGICO (ca mama, leucemia o linfoma) con tto de antraciclinas / trastuzumab con IC sistólica aguda. Tb se da en tto con ciclofosfamida.
- MIOCARDIOPATÍA ESTRESANTE/TAKOTSUBO	Mujer postmenopáusica que sufre un evento estresante y comienza con: - Dolor anginoso. - Elevación de troponina. - Elevación del ST en ECG. - Disfunción sistólica aguda. Coronariografía: NORMALES. Reversible y recidivante.
DISPLASIA - ARRITMOGÉNICA DEL VD	Jóvenes deportistas que sufren de muerte súbita (disfunción diastólica del VD). ECG: ONDA T NEGATIVAS EN V1-V3 Y onda epsilon (+ específico). AF: Muerte súbita.
MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA	IC diastólico + dilatación biauricular + clínica de fallo derecho (aumento del PVY, PVY en "raíz cuadrada"). ECG: Voltajes bajos. En el cateterismo: presión de llenado ventriculares elevadas: PVI > 5 mmhg > PVD y bajo gasto cardiaco.
- AMILOIDOSIS PRIMARIA	Miocardopatía restrictiva en paciente con mieloma múltiple. Eco: corazón moteado brillante.
AMILOIDOSIS - TRANSTIRRETINA (TTR)	Miocardopatía restrictiva + anciano varón con síndrome del túnel del carpo + neuropatía + rotura traumática del tendón del bíceps. Dx: gammagrafía tc 99- DPD /Pirofosfato. Tto TAFAMIDIS.
- HEMOCROMATOSIS	Miocardopatía restrictiva + disfunción hepática + diabetes + pigmentación de la piel.
- SD LOEFFLER	Mioc. Restrictiva + fibrosis del endocardio + endocarditis eosinofílica.

- ENFERMEDAD DE DAVIS	Fibrosis endocárdica + /- afectación valvular en jóvenes que proceden de países tropicales/ subtropicales de África.
MIOCARDITIS	COXSACKIE B Dolor torácico pericárdico (Eleva troponinas).
- MIOCARDITIS DE CÉLULAS GIGANTES	Muerte súbita + Anato P : células MULTINUCLEADAS.
- MIOCARDITIS POR RADIACIÓN	Paciente que ha recibido RDT y desarrolla: - Miocarditis. - Fibrosis valvular → insuficiencia valvular. - Calcificaciones.
TEMA 6	VALVULOPATIAS
ESTENOSIS AÓRTICA	Varón con disnea progresiva de esfuerzo + angina + síncope Pulso parvus et tardus Chasquido de apertura + soplo mesosistólico que irradia a carótidas. ECG : HIPERTROFIA VENTRICULAR.
INSUFICIENCIA TRICÚSPIDE	Soplo sistólico que aumenta con la inspiración + ondas V prominente en PVY.
INSUFICIENCIA AÓRTICA	Varón anciano con palpitaciones + disnea de esfuerzo moderado. Latido vascular prominente cervical (latido hiperdinámico "latido magnus, celer, altus"). Soplo diastólico de alta frecuencia acompañado de soplo sistólico de hiperaflujo. Soplo de Austin-flint : soplo diastólico regurgita sobre la valva anterior de la válvula mitral.
PROLAPSO MITRAL	Mujeres jóvenes (30a) con collagenopatías con dolor torácico atípico y soplo que es AUMENTA Con valsalva.
SD DE WILLIAMS BEUREN	Estenosis aórtica supravalvular + hipercalcemia + retraso mental + típica cara de duende.
TEMA 7	PERICARDIO
PERICARDITIS AGUDA	Joven con antecedente de catarro + dolor torácico de varios días de evolución y que aumenta con los movimientos respiratorios. ECG : ascenso difuso del ST y descenso del ST en AvR y descenso del PR.

TAPONAMIENTO CARDIACO	Paciente con cuadro agudo de hipoTA e ingurgitación yugular (SHOCK cardiogénico) con pulso paradójico y ECG : bajo voltaje + alternancia eléctrica + Taquicardia sinusal. AP: neoplasia (derrame hemático: metástasis).
PERICARDITIS CONSTRICTIVA	ICC derecha crónica en un paciente que ha tenido pericarditis, o cirugía cardíaca o ha recibido RT. Signo de Kussmaul. Dip Platteau. Te pueden poner paciente a estudio de hepatitis o cirrosis que no le encuentran causa hepática.
TEMA 8	CARDIOPATIAS CONGÊNITAS
CIA	Mujer + Desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono + bloqueo de rama derecha (dilatación del VD).
CIV	Soplo rudo y pansistólico en región paraesternal izquierda. A más intensidad □ más pequeña es.
DAP	Prematuro + soplo continuo en maquinaria de Gibson infraclavicular izquierda + cianosis en miembros inferiores con miembros superiores bien oxigenados.
COARTACIÓN DE AORTA	Varón joven HTA con HVI con: - Claudicación de la marcha + disfunción eréctil + pulso débil femoral. - Soplo sistólico que puede ser continuo irradia a espalda.
TETRALOGÍA DE FALLOT	Niño >1 año que cuando llora se pone azul. Estenosis pulmonar + HVD + CIV + cabalgamiento de la aorta. Soplo sistólico + acropaquias.
ANOMALÍA DE EBSTEIN	Insuficiencia tricúspide + CIA + WOLF PARKINSON WHITE
D- TRANSPOSICIÓN DE GRANDES ARTERIAS	Recién nacido azul.

TEMA 9	TUMORES CARDIACOS
MIXOMA AURICULAR	Paciente con fiebre + soplo diastólico que MODIFICA CON LA POSTURA + plop tumoral con hemocultivos NEGATIVOS +/- émbolos periféricos (nódulos de Osler) .
TEMA 10	ARRITMIAS
DISFUNCIÓN DEL NODO SINUSAL	Abuelito que toma antiarrítmico.
IMPLANTE DE MARCAPASOS	Paciente anciano + síncope + ECG.
FLUTTER AURICULAR	Varón + EPOC.
TRIN	Mujer joven con palpitaciones en el cuello + ECG con <u>taquicardia de QRS estrecho que cede a adenosina.</u>
ORTODRÓMICA	Varón joven + sano + ECG con PR corto + QRS estrecho + onda delta.
TV	QRS ancho + antecedente de IAM.
TEMA 13	ENFERMEDAD CORONARIA
SÍNDROME X	Mujer + angina de esfuerzo + <u>Prueba de imagen positiva</u> + Coronariografía normal.
ANGINA ESTABLE	Dolor típico + cede en reposo/nitratos + surge en esfuerzos. No más de 10 min.
ANGINA DE PRINZMETAL	Joven fumador + dolor de reposo por la noche. <u>ECG:</u> elevación ST Responde a Nitratos y a calcio antagonista.
ANEURISMA VENTRICULAR	Persistencia de <u>la elevación del segmento ST</u> de varias semanas en zonas de IAM.
ROTURA DE PARED LIBRE	Mujer anciana con un infarto anterolateral extenso previo que entra de manera súbita en parada cardíaca. Ingurgitación yugular. ECG disociación electromecánica.

ROTURA DEL MÚSCULO PAPILAR	EAP + Insuficiencia mitral (soplo en ápex) y shock por un infarto previo en cara inferior.
INFARTO DE VD	Infarto en cara inferior con HIPOTENSIÓN + INGURGITACIÓN YUGULAR + PULMONES NORMALES.
TEMA 15	ENFERMEDADES DE LA AORTA
LOEYS-DIETZ	Paladar hendido + úvula bipartida + necrosis quística de la íntima (ANEURISMAS DE AORTA TORÁCICA ASCENDENTE).
DISECCIÓN AÓRTICA	Varón joven con necrosis quística de la media (Marfan, ehler danlos, Loeys Dietz) o MANOLO HIPERTENSO con todos los FRCV que tiene un dolor torácico de gran intensidad (desgarrador) migratorio hacia la espalda, pulso diferencial entre miembro superior derecho e izquierdo, soplo diastólico, y ensanchamiento mediastínico de tórax. - MARFAN: chico joven, Muy alargado, con afectación cardíaca de curso rápido que le lleva a la muerte.
TEMA 16	ENFERMEDAD VASOS PERIFÉRICOS
ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA	Abuelita con FA o varón mayor con FRCV con isquemia arterial crónica como AP.
ESTENOSIS ARTERIA RENALES	Paciente al que le pones IECA/ARAI y empeora de manera súbita la función del riñón.
SD DE LERICHE	TRIADA: Claudicación glútea + Impotencia + Ausencia de todos los pulsos distales.
OTROS	
CÁNCER + DISNEA	Tromboembolismo pulmonar + BRD + hemibloqueo posterior izquierdo.

CIRUGÍA GENERAL

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 3	COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
ABSCESO INTRAABDOMINAL	Fiebre en agujas (en picos) a los 6-10 días de la operación quirúrgica.
TEMA 6	CIRUGÍA PLÁSTICA

SD DE INHALACION	Paciente quemado en sitio cerrado/ con quemaduras en cara y cuello /inconsciente que ha inhala do humo tiene un edema pulmonar y distrés respiratorio asociado . Analítica acidosis láctica con lactato elevado .
LINFOMA ANAPLASICO DE CELULAS GIGANTES	Paciente con un implante de larga evolución (>7años) con un seroma que es CD30 + Y ALK - .
CONTRACTURA CAPSULAR	Mujer que viene con la mama deformada y mucho dolor y tiene un implante .
TEMA 4	INFECCIONES INTRAABDOMINALES
PERITONITIS TUBERCULOSA	Mujer joven de origen endémico con cuadro crónico de fiebre, dolor, pérdida de peso y ascitis . Líquido: Linfocitos, prot>3g, ↑ADA Múltiples tubérculos duros sobreelevados en peritoneo, epiplón y mesenterio.
PERITONITIS GRANULOMATOSA	Dolor abdominal y obstrucción a las 2-6 sem de una operación . Líquido: PATRÓN EN CRUZ DE MALTA.
ABSCESO HEPÁTICO PIÓGENO	Dolor en hipocondrio derecho + fiebre en picos + ap: <u>colangitis/coledocolitiasis/estenosis biliar/CPRE/colecistitis aguda/anastomosis biliodigestiva.</u> + signos de sepsis
ABSCESO AMEBIANO	Paciente con lesión hepática única grande derecha + fiebre + diarrea + antecedentes de viaje a zona tropical
ABSCESO POR HIDATIDOSIS	“ Signo de copos de nieve” □ activo. “en panal de abeja” □ activo.
TEMA 9	POLITRAUMATISMO
HEMOBILIA	Paciente con lesión en el hígado al que se le interviene quirúrgicamente y comienza con dolor en hipocondrio derecho, Hemorragia digestiva alta e ictericia.

TRÍADA LETAL DEL POLITRAUMATIZADO	Hipotermia + acidosis + coagulopatía
HEMATOMA RETROPERITONEAL	Paciente politraumatizado con shock SIN localizar foco de hemorragia con HEMATURIA, MASA EN FLANCOS, SIGNO DE GREY TURNER. NO TIENE IRRITACIÓN PERITONEAL.
LESIÓN DEL ÁRBOL TRAQUEOBRONQUIAL	<u>Hemoptisis enfisema subcutáneo y mediastínico</u> con neumotórax que no mejora con el drenaje. Signo de Hamman.
LESIÓN DE GRANDES VASOS	<u>Ensanchamiento mediastínico (<8cm)</u> en rx tórax en un politraumatismo + pérdida del botón aórtico `desviación de la tráquea.
ASFIXIA TRAUMÁTICA	Aplastamiento/buzos que coloración violácea en la cabeza y parte superior del tórax + petequias + hemorragias subconjuntivales +/- pérdida de visión
HERNIA INGUINAL/FEMORAL	Varón fumador/EPOC que tiene una masa /dolor en región inguinal que aumenta con cambios de posición y esfuerzo.
HERNIA OBTURATRIZ	Anciana con dolor que irradia a muslo y cuadros obstructivos.

DERMATOLOGÍA

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
HAND-SCHULLER-CHRISTIAN (Histiocitosis de células de Langerhans crónica diseminada):	2-5a, huesos planos + proptosis + diabetes insípida
LETTERER-SIWE (HCL aguda diseminada)	<2a, erupción seborreica, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, pulmón y diarrea.
MALACOPLAQUIA	Inmunocomprometidos con aparición de placas amarillentas que presentan los cuerpos de MICHAELIS-GUTMANN INTRACELULARES Y PAS + . TTO: ANTIBIÓTICOS /RESECCIÓN QX
PLUMBOPORFIRIA O PORFIRIA DE DOSS.	Porfiria se relaciona con la intoxicación por plomo . AR y déficit de ALA-D (deshidratasa).
SÍNDROME DE GORLIN-GOLTZ	Quistes maxilares + basocelulares en áreas no fotoexpuestas + pits palmoplantares AUTOSÓMICO DOMINANTE
SIGNO DE LESER-TRÉLAT	Brotes múltiples de queratosis seborreica pruriginosa. Se asocia a adenocarcinoma gástrico , entre otros.
ESCLEROSIS TUBEROSA	Herencia: Autosómica Dominante (AD). Clínica: Crisis + Retraso mental + Angiofibromas faciales + Rabdomiomas cardíacos. - A nivel cerebral: nódulos subependimarios, tubers corticales y astrocitomas gigantocelulares subependimarios. NO neurinomas.
MOLUSCO CONTAGIOSO	Pequeñas pápulas hemisféricas umbilicadas localizadas tanto en piel como en mucosas.
SD DRESS	Es una reacción adversa a fármacos caracterizada por malestar general + fiebre. • Malestar general. • Rash generalizado. • Eosinofilia. • Linfocitos. • Adenopatías. • Edema facial. • Aumento de transaminasas. * Se debe a una

DIGESTIVO

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 3	TRASTORNOS MOTORES DEL ESOFAGO
ACALASIA	Paciente 30-50 años con disfagia a sólidos y líquidos de manera continua con regurgitación (PERO NO PIROSIS) PÉRDIDA DE PESO Y DOLOR TORÁCICO.
EED	Paciente con disfagia a sólidos y líquidos de manera intermitente con dolor torácico retroesternal.
ESCLERODERMIA	Disfagia a sólidos y líquido con RGE (PIROSIS)
TEMA 4	ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL ESOFAGO
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA	Joven con AP de atopia/alergia que tiene disfagia /dolor abdominal-torácico/ RGE que no responde a tto / en niños: rechazo de tomas, pérdida de peso Esófago traquealizado y más de 15 eos/campo.
PERFORACIÓN ESOFAGO	Tríada de Mackler: <u>dolor torácico + vómitos + enfisema subcutáneo.</u> RX: Desplazamiento anterior de la tráquea/ ensanchamiento mediastino superior o del espacio retrovisceral/ aire en espacios hísticos.
SD DE PLUMMER VINSON	Disfagia en mujer de edad media + anemia ferropénica + glositis. Riesgo: carcinoma esofágico.
TRIADA DE SAINT	Diverticulosis colónica + coleditiasis + hernia de hiato.
SÍNDROME DE MENDELSON	Neumonitis química secundaria a reflujo gastroesofágico
ENFERMEDAD DE MALLORY-WEISS	Hematemesis en pacientes que presentan vómitos intensos.
TEMA 8	GASTRITIS
GASTROPARESIA	DIABÉTICO con vómitos, distensión abdominal, plenitud + pérdida de peso. <u>DX:</u> vaciamiento gástrico con radioisótopos.
ÚLCERAS DE CURLING	Úlceras de estrés (realmente no es una úlcera porque no pasan la muscular) y son múltiples en pacientes quemados situadas en el fundus y cuerpo.

ÚLCERAS DE CUSHING	Úlceras de estrés asociadas a lesiones del sistema nervioso central, ya sean traumatismos o intervenciones.
ENFERMEDAD DE IMERSLUND-GRÄSBECK	Deficiencia de receptores ileales para factor intrínseco
SÍNDROME DE WILKIE	- Náuseas y vómitos profundos + Distensión abdominal + Adelgazamiento + Epigastralgia postprandial. TTO: Duodenoyeyunostomía.
TEMA 9	GASTROPATÍAS HIPERPLÁSICAS
MENETRIER	Dolor epigástrico + anasarca Histo: hipertrofia de pliegues (pseudogastritis) Hipoproteinemia e hipoclorhidria.
SD ZOLLINGER ELLISON	Dolor epigástrico + Úlceras de localización atípicas y refractarias al tto + esteatorrea.
TEMA 10	ÚLCERA PÉPTICA H. PYLORI Y AINES
PERFORACIÓN DE ÚLCERA	Paciente con ap de úlcera péptica /consumo de AINE que dolor epigástrico súbito + abdomen en tabla + signos de sepsis.
TEMA 11	SÍNDROMES MALABSORTIVOS
SOBRECIMIENTO BACTERIANO	Clínica: Diarrea + Esteatorrea + Anemia + Pérdida de peso + Desnutrición.
TEMA 15	CÁNCER COLORRECTAL HEREDITARIO ASOCIADO A POLIPOSIS Y SÍNDROME DE LYNCH
SÍNDROME DE LYNCH	Caracterizado por: Desarrollo precoz + CCR + Predominio de colon derecho + Elevada tendencia a presentar lesiones sincrónicas o metacrónica + Neoplasia de otro origen (endometrio, estómago, páncreas, sistema urinario, ovario, vías biliares, intestino delgado, cerebro y piel).
TEMA 16	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
COLITIS ULCEROSA	Afectación mucosa continua, clínica de rectorragia (frecuente la ileítis por reflujo) AC: P-anca

COLITIS MICROSCÓPICA	- Diarrea acuosa sin sangre, crónica o recidivante. - Mucosa colónica macroscópicamente normal. - Hallazgos histopatológicos característicos de la mucosa del colon.
TEMA 20	CIRUGÍA DE LA ENFERMEDAD DIVERTICULAR
DIVERTICULITIS AGUDA	Varón >60 años con dolor en FII + irritación peritoneal + fiebre + leucocitosis con desviación izquierda
DIVERTÍCULO DE MECKEL	Hemorragia digestiva baja en paciente joven.
DUODENO YEYUNO-ILEAL	Neumoperitoneo instantáneo sin perforación ni peritonitis.
TEMA 23	OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
SD FITZ-HUGH- CURTIS	Suboclusión en mujer joven con perihepatitis con EIP de c.trachomatis/Neisseria.
COMPRESIÓN VASCULAR DEL DUODENO (	Mujer joven deportista con escoliosis y cuadro obstructivo.
SD DE OGILVIE	Abuelito con dilatación del colon transversal/derecho SIN CAUSA OBSTRUCTIVA Y SIN NIVELES HIDROAÉREOS Que responden a NEOSTIGMINA IV.
TEMA 24	PATOLOGÍA VASCULAR INTESTINAL
IMA EMBÓLICA	Dolor abdominal brusco + exploración normal con distensión abdominal con FA/Arritmias.
IMC REAGUDIZADA	Dolor desproporcionado a la exploración física en un paciente con pérdida de peso y miedo a comer.
COLITIS ISQUÉMICA	Paciente anciano Diabético /diálisis/HTA + dolor cólico izquierdo + rectorragia + dolor abdominal + diarrea Paciente con dolor cólico izquierdo + rectorragia + dolor abdominal + diarrea con Antecedente de cirugía aórtica. Paciente corredor de maratón y bajo gasto con dolor cólico izquierdo + rectorragia + dolor abdominal + diarrea.
ANEURISMA DE LA ARTERIA HEPÁTICA	Mujer embarazada con RX de abdomen: "calcificaciones en anillo de sello" en hipocondrio izquierdo.

ANGIODISPLASIA INTESTINAL	>60 años con rectorragia recidivante, leve y autolimitada.
TEMA 26	ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA
SD GILBERT	Joven de 20 años con ictericia intermitente que coincide con situaciones de estrés (ayuno, deporte, fiebre, infección, ingesta de alcohol). Bilirrubina indirecta <5. Con función hepática e histología normales "alteraciones mitocondriales".

TEMA 29	HEPATITIS AUTOINMUNE
HEPATITIS AUTOINMUNE I	Mujer blanca europea + descarte de otras hepatitis y aumento de títulos de AC- ANA /AML.
HEPATITIS AUTOINMUNE II	Mujer blanca europea + descarte de otras hepatitis y aumento de títulos de AC- ANTI-LKM-1//ANTI-LC-1.
TEMA 30	TRASTORNOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL
HEPATITIS AGUDA ALCOHÓLICA	Paciente que bebe mucho con una hepatitis muy light (ligero aumento de transaminasa), mínima leucocitosis y con ictericia. Analítica: anemia macrocítica ($\uparrow$ VCM), GOT>ALT (2), Y $\uparrow$ GGT AP: HIALINA DE MALLORY //CUERPOS DE COUNCILMAN.
TEMA 32	COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS
SINDROME HEPATORENAL	Cirrótico + ascitis + oliguria + $\uparrow$ creatinina + EFNaO<1% que no responde a expansión de volumen + albúmina.
TEMA 33	COLESTASIS CRÓNICA
COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA	Varón de 40 años +/- colitis ulcerosa + aumento de enzimas colestásicas + asintomático: - <i>colangitis de repetición.</i> - <i>Colangiocarcinoma.</i> - CPRE "CUENTAS DE ROSARIO". - BIOPSIA "CAPAS DE CEBOLLA."
COLANGITIS BILIAR PRIMARIA	Mujer 40-60 años + con otra enfermedad autoinmune + asintomática + enzimas colestásicas + AMA tipo 2(+).
TEMA 34	ENFERMEDADES METABÓLICAS HEPÁTICAS
ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA	Paciente con muchos FRCV (HTA, DM, Obeso) con elevación de las transaminasas y estudio de la etiología de enfermedad hepática crónica NEGATIVO.

HEMOCROMATOSIS	Varones/mujeres postmenopáusica con diabetes mellitus + pigmentación bronceada Niveles de Fe muy altos. IST > 45% y Ferritina alta.
ENF DE WILSON	Existen dos tipos de pacientes: - Paciente con <u>clínica neurológica/psiquiátrica</u>. - Paciente con <u>hepatitis aguda que da un fallo hepático fulminante</u>. Ambos: anillo de kayser Fleischer// CÉLULAS DE OPALSKI Y GLÍA TIPO II EN Alzheimer. Analítica: ↓ceruloplasmina sérica y cobre sérico ↑cobre libre, cobre total y cobre urinario.

TEMA 35	TUMORES HEPATICOS
ADENOMA HEPATOCELULAR	Mujer <50ª que toma anticonceptivos orales/SOP/embarazo. Hombre que consume agentes anabolizantes androgénicos. RM/TAC con gadolinio: LOE con SIN cicatriz.
HIPERPLASIA NODULAR FOCAL	Mujer edad fértil + asintomática con masa abdominal palpable RM/TAC con gadolinio: LOE con una CICATRIZ CENTRAL .
KASABACH MERRIT	Hemangioma hepático + <u>coagulopatía de consumo</u> + <u>trombopenia de consumo</u> .
TEMA 36	ENFERMEDAD DE VESÍCULA BILIAR Y CONDUCTOS BILIARES
ILEO BILIAR	Aerobilia + signos de obstrucción (distensión abdominal y disminución de peristaltismo). TRIADA DE RIGLER: aerobilia + obstrucción + cálculo en fosa iliaca (<50% casos) Más frecuente en <u>mujeres ancianas</u> .
COLEDOCOLITIASIS RESIDUAL	Paciente colecistectomizado con cuadro de ictericia/colangitis con FA elevada y vía biliar dilatada .
SD BOUVERET	cálculo en bulbo duodenal debido a una fístula colecisto/coledocoduodenal y produce una obstrucción gástrica.
COLANGITIS	TRIADA DE CHARCOT: • Dolor en hipocondrio derecho. • Fiebre. • Ictericia.
TEMA 38	PANCREATITIS AGUDA
PSEUDOQUISTE	Persona que ha tenido un cuadro de pancreatitis aguda y tras 4 SEMANAS la AMILASA PERSISTE ALTA . NO hay dolor.
TEMA 40	TUMORES DEL PANCREAS EXOCRINO
CANCER DE PANCREAS	Paciente mayor con ictericia y pérdida de peso SIN dolor . ECO: Dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. CPRE: Estenosis abrupta del colédoco distal.

ENDOCRINO

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 2	ENFERMEDAD DE LA HIPÓFISIS -HIPOTÁLAMO
ACROMEGALIA	Persona que ha tenido que cambiar de anillo/zapatos/ manos grandes/ generalmente diabético con sudoración pastosa y ronquera. PIES GRANDES /MANOS GRANDES.
SD DE LAURENCE MOON BIELD <i>LAURA SE QUEDO CIEGA Y TONTA MIRANDO A LA LUNA</i>	<u>Retraso mental + degeneración retiniana + hipogonadismo hipogonadotrofo</u>
SD DE KALLMAN	Varón + atrofia testicular + Hipogonadismo hipogonadotrofo + <u>anosmia /hiposmia `hipotrofia testicular, criptorquidia, malformación renal.</u>
SD DE NELSON	Paciente con enf de Cushing que se sometían a cirugía hipofisaria □ no se curaban □ suprarrenalectomía bilateral □ tumor.
HIPOFISITIS LINFOCITARIA	HiperPRL y Diabetes insípida en embarazo y postparto.
SD SHEEHAN	Mujer que no puede dar lactancia y ha tenido un parto con mucho sangrado e hipotensión, generalmente instrumentalizado.
SD DE WOLFRAM <i>GORDO, QUE MEA MUCHO, VE POCO Y ESCUCHA MENOS</i>	DIDMOAD. Diabetes insípida central. Diabetes mellitus. Atrofia óptica. Sordera neurosensorial (deafness).
TEMA 3	TIROIDES
SD DE PRENDRED	Bocio + sordera neurogénica + hipotiroidismo (AR).
CA. FOLICULAR	Joven que ha recibido RT. AP: PSAMMOMAS (<i>Calcificaciones en grano de arena</i>) y PAPILAS.
CA MEDULAR	Pensar en el cuándo: asocia feocromocitoma o en AP: SUSTANCIA AMILOIDE. ADENOPATÍAS CALCIFICADAS. ↑CALCITONINA/CEA/CROMOGRANINA.

COMA MIXEDEMATOSOS	Anciano + coma + hipotermia + bradicardia que ha estado expuesto a temperaturas frías/sepsis /cirugía.
TIROIDITIS SUBAGUDA VIRAL DE QUERVAIN/GRANULOMATOSA/DE CÉLULAS GIGANTES	Paciente que ha tenido cuadro catarral de vías altas hace unas semanas y viene con dolor en la parte anterior del cuello , fiebre , malestar general . Exploración: cuello agrandado CON NÓDULOS . Gammagrafía: hipocaptante. AP: células gigantes . Analítica: aumento de VSG .
TIROIDITIS FIBROSANTE DE RIEDEL	Paciente de mediana edad con tiroides aumentado de tamaño y de consistencia pétrea SIN afectación de ganglios linfáticos residuales .
TIROIDITIS SUBAGUDA	Mujer joven con odinofagia intensa de 2 días de duración, con mialgias y tos seca 10 días antes , con alivio la semana anterior. Está temblorosa y con sudoración . No muestra eritema o exudado faríngeo, sí dolor a la palpación en región anterior cervical baja, sin nódulos, masas ni adenopatías . Tiene pulso de 110 lpm, 38,2°C y ligero temblor en reposo. RESUMEN: Cuadro gripal con dolor intenso en zona de tiroides + tirotoxicosis.
TEMA 4	GLANDULA SUPRARRENAL.
SD CUSHING ECTÓPICO CÁNCER MICROCÍTICO DE PULMÓN	Hiperglucemia, hipopotasemia, alcalosis metabólica, miopatía proximal e hiperpigmentación en un paciente con patología neoplásica (fumador, asténico y pérdida de peso) .
SD DE ADISON	Mujer + insuficiencia suprarrenal + otros cuadros autoinmunes + molestias digestivas + dolor abdominal + pérdida de peso e hiporexia + hipoglucemia + hiponatremia + hiper K + acidosis metabólica + hiperpigmentación AC anti 21-hidroxilasa (confirman dx)
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL TBC	Insuficiencia suprarrenal + calcificaciones suprarrenales
SD COON	Hiperaldosteronismo HTA + HIPOPOTASEMIA
SD DE SUTHERLAND(HIPERTENSIÓN FAMILIAR TIPO I) AD.	HTA en la infancia o HTA grave y accidentes cerebrovasculares en una persona joven.

TRIADA DE CARNEY	- GIST + Paraganglioma + cordoma pulmonar
TEMA 5	DIABETES
DIABETES LADA	Paciente DM 2 NO OBESO Que no responde bien a los antidiabéticos orales ni a la dieta.
DIABETES POR DEFECTOS DE ADN MITOCONDRIAL	Diabetes con sordera o sospecharla si con metformina hace una acidosis láctica
COMA HIPEROSMOLAR	Anciano con DM2 + infección + disminución de conciencia + glucemia >600.
DIABETES MODY	Es una diabetes genética de herencia dominante poco frecuente. Afecta a las células beta del páncreas. Hay 6 tipos. - La más común: MODY tipo II (se diagnostica en infancia).

TEMA 7	NUTRICIÓN
SD DE REALIMENTACION	Paciente muy desnutrido al que se le pone soporte nutricional (enteral o parenteral) sobre todo) y a los 3 días empieza con HIPOK, HIPOMG, HIPOP, DIARREA EDEMA CON FÓVEA .
ENFERMEDAD DE TANGIER	Cifras bajas de HDL desde el nacimiento (AR). Presenta linfadenopatía e hipertrofia amigdalara naranja (tangier=tangerina) .
hipercolesterolemias secundarias	CAUSAS: - DM /IRC / Hipotiroidismo /Cirrosis biliar primaria
Hipercolesterolemia familiar homocigota	Características: colesterol total >500 + Xantomas + Enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura y progresiva.
hipercolesterolemia familiar heterocigótica:	Características: Concentraciones elevadas de LDL + Xantomas tendinosos + Aterosclerosis + Enfermedad cardiovascular prematura.
TEMA 8	METABOLISMO DEL CALCIO
OSTEODISTROFIA HEREDITARIA DE ALBRIGHT	Pseudohipoparatiroidismo tipo IA (estatura baja`cara redondeada + obesidad + pseudo pterigium colli + acortamiento del 4-5 metacarpiano).
DÉFICIT FUNCIONAL DEL RECEPTOR DE VITAMINA D (RAQUITISMO RESISTENTE A D3, O RAQUITISMO TIPO 2).	<u>Alopecia total</u> en un niño con <u>raquitismo grave</u>
TEMA 9	TRASTORNOS QUE AFECTAN A MÚLTIPLES ÓRGANOS ENDOCRINOS
COMPLEJO DE CARNEY	MEN que se caracteriza por nevus azules y lentiginosis .
SÍNDROME POLIGLANDULAR TIPO 1	TRIADA: - Candidiasis. - Hipoparatiroidismo. - Insuficiencia suprarrenal.
NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 1	TRIADA: - Hiperparatiroidismo. - Tumores de células insulares del páncreas. - Tumores hipofisarios.
NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE 2A	TRIADA: - Carcinoma medular de tiroides. - Feocromocitoma. - Hiperparatiroidismo.

TEMA 10	TUMORES NEUROENDOCRINOS GASTROENTEROPANCREÁTICOS. TUMOR Y SÍNDROME CARCINOIDE
VIPOMA	TRIADA - Diarrea secretora >3L/día - Hipopotasemia - Hipoclorhidria
PPOMA	- Pérdida de peso. - Dolor abdominal. - Ictericia. - Diarrea. - Masa abdominal. *Hipersecreta polipéptido pancreático.
GLUCAGONOMA	Eritema necrolítico migratorio + Diabetes mellitus.
INSULINOMA	- Hipoglucemia. - Aberraciones mentales en ayunas. - Obesidad en mujer joven.
TEMA 11	TRASTORNOS DEL DESARROLLO SEXUAL
SD DE ROKITANSKY	Mujer con amenorrea primaria, agenesia de vagina, ausencia de útero, ovarios normales, cariotipo 46XX normal.

HEMATOLOGÍA

TEMA	APLASIA DE MEDULA ÓSEA
APLASIA DE MÉDULA ÓSEA	Pancitopenia con reticulocitos bajos con sd anémico + infecciones + hemorrágicos. MO: <u>hipocelular con aumento de grasa.</u>
ANEMIA DE FANCONI	AR (alguien joven). Con aplasia de médula ósea + manchas cafés con leche + hipoplasia del pulgar y del radio. Aumento de Neoplasia de órgano sólido + LMA.
TEMA 3	ANEMIA MIELOPTÍSICA
ANEMIA MIELOPTÍSICA	Paciente con tumor de órgano sólido de base con Analítica: anemia +/- citopenia Frotis: <u>aumento de células inmaduras</u> (Reacción leucoeritroblástica). - Normoblasto y reticulocitos. - Cayados/ mielocitos / metamielocitos. - Plaquetas gigantes DACRIOCITOS.
MIELOFIBROSIS PRIMARIA	MIELOPTISIS + HEPATOESPLENOMEGALIA
TEMA 5	ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS
DÉFICIT DE VIT B12	VCM > 100 fl + tinte amarilla (bilirrubina indirecta) + clínica neurológica: <u>pérdida de sensibilidad vibratoria y posicional + hormigueos.</u> NEUTROFILOS HIPERSEGMENTADOS.
TEMA 7	ANEMIAS HEMOLITICAS
ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	Paciente joven con anemia hemolítica extravascular con LITIASIS BILIARES.
TALASEMIA MINOR	Mujer o varón de unos 30 años con anemia leve y la exploración física normal. VCM disminuido + nº hematíes normales o ligeramente elevados. <u>HBA1 disminuida.</u> <u>HBA2 aumentada.</u> <u>HBAF normal.</u>
DREPANOCITOSIS	Paciente de país africano /caribe (Jamaica). Anemia + crisis dolorosas (crisis vasooclusivas). Lesiones cutáneas ulceradas. Drepanocitos: hematíes son falciformes.
HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA	Anemia hemolítica + (hemoglobinuria) + pancitopenia + trombosis sobre todo venosas.

PTT	Clínica neurológica + anemia hemolítica Coombs negativos + plaquetopenia. Tto plasmaféresis urgente. Frotis: ESQUISTOCITOS.
TEMA 8	SINDROME MIELODISPLASICO
SINDROME MIELODISPLASICO	Varón de más de 70 años con anemia normo-macroscítica que no responde al tto. ES UNA ANEMIA CRÓNICA +/- INFECCIONES +/- HEMORRAGIAS. Joven sometido a QT /RT. NEUTRÓFILOS HIPOSEGMENTADOS.
TEMA 10	SD MIELOPROLIFERATIVOS CRONICOS
POLICITEMIA VERA	Varón de edad media que se queja de piel roja/cefalea/mareas/acufenos/prurito/pérdida de peso/HTA e hipersensibilidad ósea. Con hepatoesplenomegalia. ANALITICA - Disminuye VCM. - Aumento de eritrocitos, plaquetas y neutrófilos. - Aumento de fosfatasa alcalina leucocitaria. - Aumento de vit b12. - DISMINUCIÓN DE LA EPO. MO: Aumento las tres series celulares.
LMC	Varón de 50-60 años con astenia, pérdida de peso, saturación nocturna y hepatoesplenomegalia Analítica: - Anemia normo-normo. - Aumento de la serie blanca (células maduras y blastos). - Trombopenia a trombocitosis. - Disminución de la fosfatasa alcalina leucocitaria. MO: hiper celular aumento ratio mieloide/eritroide.
TEMA 11	LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICO
LLC	Varón de 70 años con síntomas B (fiebre + pérdida de peso + sudoración nocturna) Analítica: linfocitosis (de linf B) +/- anemia +/- trombopenia. Disminución de ih. Exploración: adenopatías + hepatoesplenomegalia. Frotis de sangre: manchas de Gumper. LINFOCITO B CON CD 5+.

TRICOLEUCEMIA	Persona de edad media con Citopenias + hepato esplenomegalia SIN ADENOPATÍAS <u>Frotis de sangre:</u> célula peluda. <u>Tinción fosfatasa ácida resistente al tartrato.</u> LINFOCITO B CD 25+
TEMA 12	LEUCEMIAS AGUDAS
LEUCEMIA AGUDA	Varón >60 (LMA) /niños (LLA). Anemia + infecciones + hemorragias + infiltración de blastos: - MO >20% blastos. Hepatoesplenomegalia (LAL). SNC (+ frec en LAL). Disfunción orgánica.
LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA M3	Mieloperoxidasa + T(15,17). Bastones de auer. Alteración de la coagulación /hemorragias. Tto: ácido transretinoico + trióxido de arsénico.
SÍNDROME DE DI GUGLIELMO	M6 o eritroleucemia (glicoforina +) y cariotipo complejo.
TEMA 13 Y 14	LINFOMAS
LINFOMAS HODGKIN	Pacientes jóvenes con múltiples adenopatías + síntomas B + (pérdida de peso / sudoración nocturna / fiebre) + prurito. Las adenopatías pueden doler tras la ingesta de alcohol (hoster). Celulita de red Sternberg (CD 15+, CD30+ CD 20 - /CD 45-). TTO ABDV +/- RT (de forma general).
LINFOMA HODGKIN ESCLEROSIS NODULAR	Mujer joven con afectación adenopatías mediastínicas y prurito.
LINFOMA NO HODGKIN	Pacientes jóvenes con adenopatías y masa retroperitoneal, afectación extralinfática /leucemización y tb puede existir paraproteinemia. Tto (POLIQT CHOP + RITUXIMAB (De manera general).
TEMA 15	GAMMAPATÍAS

MIELOMA MÚLTIPLE	Varón más de 60 años negros con hipercalcemia + anemia + fallo renal (proteínas en orina con albúmina negativa) + lesiones óseas. (lo más frecuente: dolor óseo cráneo, costilla, columna), lesiones osteolíticas (en sacabocados). <u>Frotis de sangre periférica: pila de monedas.</u> Pico monoclonal igG. <u>MO: > 10 / células plasmáticas.</u> No adenopatías ni hepatoesplenomegalia. CD 20 – /CD 38 +
--------------------------------	---

LINFOMA LINFOPLASMOCÍTICO	Paciente con adenopatía + pico monoclonal de igM + hiperviscosidad. CD 20 +.
AMILOIDOSIS AL	Sd. del túnel carpiano, afectación renal, cadenas ligeras Lambda aumentado.
ENFERMEDAD DE CADENAS PESADAS ALFA O ENFERMEDAD DE SELIGMAN O LINFOMA MEDITERRÁNEO (<i>célula B</i>)	Linfoma que cursa con afectación de la pared intestinal y, por tanto, malabsorción. <i>*No presenta pico monoclonal en sangre, porque las Ig están atrapadas en el intestino. Difícil diagnóstico.</i>
TEMA 17	ALTERACIONES PLAQUETARIAS
PTT O SD DE MOSCHCOWITZ	Mujer edad media con: - Fiebre + plaquetopenia + anemia hemolítica traumática con esquistocitos + clínica neurológica (síndrome constitucional y parestesias) y fallo renal. AP: Trombos hialinos en arteriolas y capilares Proteína ADAMS 13 descendida. Tto: plasmaféresis + CAPLACIZUMAB
PTI	Persona joven con una infección previa que tiene únicamente plaquetas bajas y petequias. Te pueden decir plaquetas grandes. Tto: esteroides.
ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND	Sangrados superficiales (ej. Epistaxis) tras traumatismos o una cirugía. El número de plaquetas es normal. TTPA: suele estar alargado. Existe AF (AD la tipa 1 y 2).
TEMA 18	TROMBOFILIA CONGÉNITA
TROMBOFILIA CONGENITA	Trombosis venosas recurrentes en personas jóvenes que pueden tener AF.
HEMOFILIA A	Varón con hemartros y TTPA alargado. Hay AF de hemorragias
DEFICIT DE AT-III	Paciente no responde a heparina.
DÉFICIT DE PROT C O S	Necrosis cutánea tras la administración de Anticoagulantes orales.

CID	<u>Antecedente:</u> neoplásico /infección/ obstétrico/ autoinmune + Agudo □ hemorragias Crónico □ trombosis En <u>analítica:</u> - Bajo: todos los factores de la coagulación, fibrinógeno, AT-III. - Alto el <u>dímero D</u>. - ALARGADO TANTO <u>TP, TTPA como el TIEMPO DE TROMBINA.</u>
ENFERMEDAD DE WERLHOF	<u>PTI</u> <u>*Recordamos el papel de H.Pylori, como en la rosácea</u>

TEMA 19	TERAPIA ANTITROMBÓTICA
HEMORRAGIA RETROPERITONEAL POR HEPARINA	Anticoagulada con heparina y empieza con dolor lumbar, bajada de tensión, taquicardia, palidez y anemia que se corrige con las transfusiones.
TEMA 20	TRASPLANTE
ENFERMEDAD VENOOCLUSIVA	Paciente que ha recibido QT Intensiva (para trasplante autólogo) con busulfan/ciclofosfamida y a las 3 semanas comienza con aumento del perímetro abdominal, ascitis, aumento de peso y hepatomegalia dolorosa. Causa HTPortal y obstrucción sinusoidal. TTO DEFIBROTIDE
EICH AGUDA	Paciente recibe un alto TPH y en menos de 100 días comienza con: - RASH CUTÁNEO DIARREA HEPATOMEGALIA (DOLOR ABDOMINAL) TTO ESTEROIDES/ PROFILAXIS: MTX-CICLOSPORINA.
TEMA 21	TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
REACCIÓN HEMOLÍTICA AGUDA	Ha recibido <u>una transfusión</u> y comienza con <u>fiebre, escalofríos, lumbalgia, hemólisis intravascular con hemoglobinuria, hipotensión y fracaso renal agudo y CID.</u>

INMUNOLOGÍA

ENFERMEDAD DEL INJERTO CONTRA EL HUÉSPED	<u>Trasplante de órgano + rash maculopapular.</u>
INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE	Triada: candidiasis + diarreas + neumonías + hipogammaglobulinemia + linfopenia + linfocitos T no funcionantes. <u>Ausencia de células plasmáticas.</u>
SD DE WISKOT ALDRICH	Eccema + trombopenia + infecciones de repetición (porque disminuye igM) Niveles de igG: normales Niveles de igA y igE aumentados Herencia recesiva ligada al x Riesgo aumentado de linfoma

GENÉTICA

SD DE NOONAN	Alteración en el gen PTNP11. Talla baja y alteraciones óseas. Fenotipo simula a sd. de Turner.
SD DE TURNER	Cariotipo 45 XO. Amenorrea primaria, talla baja, cuello alado y coartación de aorta.
SD DE DI GEORGE	Deleción del 22q11 Clínica: - Anomalías cardiovasculares (tetralogía de Fallot). - Aplasia/hipoplasia tímica. - Aplasia/hipoplasia de paratiroides (hipocalcemia). - Anomalías del paladar (voz nasal). - Retraso psicomotor.

INFECCIOSAS

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 4	NEUMONÍAS
N. KLEBSIELLA	Neumonía típica de lóbulo superior con Abombamiento de cisura en paciente alcohólico .
N. COXIELLA BURNETTI	Neumonía atípica + hepatitis con GRANULOMAS HEPÁTICOS EN COSTILLA en ganadero .
N. CHLAMYDOPHILA PISTACCI	Neumonía atípica + esplenomegalia en paciente con aves .
N. MYCOPLASMA PNEUMONIAE	Neumonía atípica en paciente joven + Miringitis bullosa /eritema nodoso/ anemia hemolítica por crioaglutininas/ neuro (ataxia o mielitis transversa) .
N. LEGIONELLA	Neumonía atípica en paciente mayor con comorbilidades + diarrea con hiponatremia e hipofosfatemia .
SD LEMIERE	Joven/niño + faringoamigdalitis □ dolor cervical □ bacteriemia y neumonía (abscesos pulmonares).
SUBEROSIS	EPID por inhalación de moho del corcho .
HISTOPLASMA	Adenopatías hiliares bilaterales calcificadas "en diana" Tto: Itraconazol (anfotericina B si grave)
TEMA 5	ENDOCARDITIS
ABSCESO EN EL TABIQUE INTERVENTRICULAR	Endocarditis aórtica + bloqueo AV .
ENDOCARDITIS UDVP	UDVP + fiebre sin foco aparente >24h o síntomas respiratorios.
BARTONELLA QUINTANA	Endocarditis con hemocultivo negativos en un indigente con lesiones cutáneas por rascado (PIOJOS).
TRIADA DE AUSTRIAN	Meningitis + endocarditis + neumonía en el mismo paciente. Todos ellos de etiología neumocócica. Más frecuente en alcohólicos.
TEMA 7	TUBERCULOSIS

TBC PULMONAR (DERRAME PLEURAL)	< 35 años + Zona de alta incidencia + dolor unilateral comienzo brusco + líquido pleural: ADA >35/ ↑INF-F + ↓AMILASA Y POCAS CELS. MESOTELIALES. NO BIOPSIA.
TUBERCULOSIS GENITOURINARIA	Síntomas miccionales crónicos + PIURIA ÁCIDA ESTÉRIL.
TUBERCULOSIS MENINGITIS	Síntomas meníngeos (convulsión) + DIPLOPÍA LCR: linfocitos + ↑Proteínas + ↓glucosa ¡Tinción puede ser Negativa!
TUBERCULOSIS PULMONAR REACTIVACIÓN	Paciente tos /hemoptisis /fiebre + Nódulo <u>cavitado</u> en LÓBULO SUPERIOR PULMONAR.

TEMA 8	DIARREAS
STAPH AUREUS	<u>Comida familiar (pasteles/cremas)</u> + cuadro <u>diarreico sin productos patológicos y vómitos en <6h</u> desde la comida.
DIARREA POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE- COLITIS PSEUDOMEMBRANOSA	Paciente que ha recibido antibiótico y a la semana empieza con diarrea sanguinolenta + fiebre, leucocitos en sangre/heces. TTO: Suspensión de antibióticos previos. Metronidazol, vancomicina o fidaxomicina.
DIARREA POR VIBRIO CHOLERA	Heces en agua de arroz/Diarrea osmótica
HISTOPLASMA CAPSULATUM	Paciente inmunodeprimido con calcificación esplénica y de los linfáticos mesentéricos.
TEMA 9	INFECCIÓN DE PARTES BLANDAS
GANGRENA GASEOSA (CLOSTRIDIUM. PERFRINGENS)	Shock séptico + CRISIS HEMOLÍTICAS + ap traumatismo + crepitación a la exploración muscular.
GANGRENA GASEOSA (CLOSTR. SEPTICUM)	Shock séptico + mionecrosis + neoplasia del tubo digestivo + crepitación a la exploración muscular.
FASCITIS NECROTIZANTE	Dolor muy exagerado en músculo + exploración física anodina y que de repente entra en shock séptico + flictenas hemorrágicas y anestesia cutánea.
TEMA 10	INFECCIONES DEL SNC
M. LISTERIA	Embarazada + diarrea + fiebre.
M. NEUMOCOCCO	TCE cerrado + Fístula LCR + meningitis de repetición.
BOTULISMO	Parálisis motora + MIDRIASIS FIJA BILATERAL con nivel de consciencia mantenido + sin fiebre.
SÍNDROME DE GARÍN-BUJADOUX-BANNWARTH	Meningoradiculitis linfocitaria: - Meningitis linfocitaria - Parálisis facial bilateral *Ocurre en el síndrome de Bannwarth, forma de neuroborreliosis precoz, desde las 4-6 semanas de la picadura.
TEMA 11	ITS
GONORREA	Varón 30 años + Activo sexualmente + uretritis. <u>Diplococos gram(-) intracelulares. (grano de café).</u>

TEMA 12	INFECCIONES Y PROFESIONES
TULARENSIS	Cazador/veterinario + fiebre + úlcera dolorosa + adenopatía regional.
ERISPELOIDE	Pescadero /carnicero QUE SE PINCHA CON UNA ESPINA DE PESCADO O HUESO DE CARNE + celulitis en miembro superior + exantema eritematoso con vesículas y pápulas.

LEPTOSPIRA	Agricultor de arroz o paciente que ha hecho actividades en agua dulce (kayak) + fiebre + cefalea + irritación meníngea + mialgia + ictericia + HEMORRAGIA CONJUNTIVAL. 2º fase: anemia hemolítica autoinmune
SD DE WEIL	Ictericia + insuficiencia renal.
CARBUNCO CUTÁNEO	Ganadero/veterinario/pastor + escara necrótica con borde edematoso y no doloroso en el dorso de la mano.
CARBUNCO POR INHALACIÓN	Fiebre + estado séptico + AUMENTO DEL MEDIASTINO + HEMOPTISIS AP: corraleros de lana.
ENF LYME	Excursión campestre en verano + eritema migratorio.
TEMA 13	INMUNODEFICIENCIAS
SD DI GEORGE	Hipocalcemia. Cardiopatía congénita. Hipoplasia del timo.
TIFLITIS	Persona <u>neutropénica + dolor FID.</u> <u>TAC ABD: IMAGEN EN DIANA.</u>
ASPERGILLOSIS INVASORA	Paciente <u>neutropénico + TAC signo del HALO</u> <u>Recuperación: SIGNO DE LA MEDIA LUNA.</u>
CANDIDIASIS CRÓNICA DISEMINADA	Paciente en <u>recuperación de neutropenia febril + fiebre + FA elevada.</u> <u>TAC BAZO: SIGNO DEL OJO DE BUEY.</u>
TEMA 15	RICKETTSIA Y OTROS
FIEBRE BOTONOSA MEDITERRÁNEA	Paciente con MEG + <u>mancha negra INDOLORA</u> <u>//Exantema maculopapuloso que afecta palmas/plantas.</u> AP: contacto con PERROS.
FIEBRE Q	Ganadero con <u>neumonía intersticial con granulomas en hígado en rosquillas// endocarditis con HC (-).</u>
BARTONELLA QUINTANA	Endocarditis con hemocultivo (-) en un indigente con lesiones <u>cutáneas por rascado (PIOJOS).</u>
BARTONELLA BACILLIFORMIS	Fiebre + <u>anemia hemolítica</u> en paciente que viene de <u>cordillera andina (Perú, Ecuador, Colombia)</u> □ <u>verrugas.</u>

TEMA 17	VIH
CANDIDIASIS ESOFÁGICA	VIH + disfagia progresiva + muguet en la cavidad oral.
CRÍPTOCOCOSIS	VIH + meningitis de curso crónico con MARCADA ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN DE APERTURA (40-50) TC: dilatación de espacio de Virchow robin.
PNEUMOCYSTIS	VIH + neumonía con infiltrado bilaterales quísticos Neumotórax y LDH↑.
LEISHMANIA	VIH + FOD + diaforesis nocturna + organomegalia + citopenia periférica. AP: contacto con perros/liebres.
CMV	VIH <100 + Pérdida de visión indolora y en FDO: hemorragias y exudados amarillentos perivasculares. VIH + <u>insuficiencia suprarrenal.</u>
SARCOMA DE KAPOSÍ	VIH + Signo del promontorio + lesiones en piel en zona proximal /mucosas.
HIPERINFESTACIÓN POR STRONGYLOIDES STERCORARIS	ID + FMO + meningitis/sepsis por enterobacterias DX: - Larvas en fluidos orgánicos TTO: ivermectina
LEUCOENCEFALOPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE	Paciente con HTA y desmielinización/focalidad posterior. Relacionado con toxicidad muy específica del bevacizumab, que también aparece en feocromocitoma, preeclampsia e inmunodeprimidos.
TEMA 18	INFECCIONES POR HONGOS
ESPOROTRICOSIS (SPOROTHRIX SCHENCKII)	Paciente (florista) que se ha pinchado con un rosal + úlcera que no cura + adenopatías.
HISTOPLASMOSIS	AP: visita a una cueva + neumonía Tras tto: calcificaciones en diana.
ASPERGILOMA	Estructura redondeada, dentro de la cavidad pulmonar, que cambia de posición con los movimientos. AP: <u>TUBERCULOSIS.</u>
MUCORMICOSIS	Paciente oncohematológico post trasplante con con neutropenia absoluta/Cetoacidosis diabética o reciben desferroxamina + dolor ocular, edema periorbitario y secreción nasal serosanguinolenta Signo del HALO REVERSO.

CRIPTOCOCOSIS	EXCREMENTOS DE PALOMA + inmunodepresión celular + meningitis crónica con hidrocefalia arreabsortiva .
TEMA 19	INFECCIONES POR PARÁSITOS
PALUDISMO	Cualquier paciente que venga de zona endémica con fiebre.
LEISHMANIASIS VISCERAL (FIEBRE NEGRA) KALA AZAR	Paciente con adenopatías generalizadas + esplenomegalia + pancitopenia + hipergamaglobulinemia policlona l. (PERROS O LIEBRES (brote en Madrid). + avanzada. Hiperpigmentación cutánea.
GIARDIA LAMBLIA	Déficit de IgA + síntomas de colon irritable (pérdida de peso, malabsorción, heces pastosas y estreñimiento).
ENTAMOEBA HYSTOLITICA	Disentería sin fiebre y sin leucocitos Absceso hepático achocolatado . Amebomas en ciego calcificadas.
TRYPANOSOMA CRUZI	Paciente de área endémica (centro/Sudamérica) + trastornos de la conducción o bloqueos de ramas en ECG .
SD LOFFLER	Tos + eosinofilia + infiltrados pulmonares fugaces . Etiología: - Ancylostoma duodenale - Necator americanus - Strongyloides stercoralis - Ascaris lumbricoides
ENTEROBIUS VERMICULARIS (OXIUROS)	<u>Bruxismo nocturno + prurito anal + lesiones por rascado perianales</u> en niño pequeño .
STRONGYLOIDES STERCOLARIS	Inmunodeprimido + infiltrados pulmonares + fracaso multiorgánico + bacteriemia/meningitis por enterobacterias.

TRIQUINOSIS	Clínica digestiva con mialgias + edema palpebral + $\uparrow$CPK + eosinofilia. AP: carne de cerdo poco cocinada/mal estado.
HIDATIDOSIS	Lesión quística de paredes finas bien delimitada en hígado /pulmón /bazo + eosinofilia.
SÍNDROME DE KATAYAMA	Fiebre autolimitada tras exposición a esquistosoma (trematodos). Se parece a la enfermedad del suero. Responde bien a praziquantel sin esteroides. La artemisina post- exposición disminuye el riesgo de aparición.

FASCIOLASIS	Ingesta de berros + fiebre + dolor en hipocondrio derecho + hiperbilirrubinemia + hepatomegalia + colangitis esclerosante + eosinofilia .
CLONORQUIASIS/OPISTORQUIASIS	COLANGIOCARCINOMAS.
ESQUISTOSOMA HAEMATOBII	Ca vejiga escamoso.
ANISAKIS	Dolor abdominal + náuseas/vómitos tras ingesta de pescado crudo (12-48h) . GASTROSCOPIA Lesión pseudotumoral en pared gástrica (clínica obstrucción) .
ESQUISTOSOMA MANSONI	Paciente natural de EGIPTO que ingresa por hematemesis y en ECO Fibrosis periportal con analítica normal .

NEFROLOGÍA

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 4	
FRA X RABDOMIOLISIS	Pte encontrado en la calle tras haber permanecido >24h con compresión muscular con importante inmovilización. (FRA + orina oscura + CPK ↑) (otros: <i>crisis comicial/ terremoto/ejercicio intenso(maratón).</i>
TEMA 5	ERC
ENF. ÓSEA ADINÁMICA	Diabético de edad avanzada + ERC + PTH < 100. ↑ de fracturas.
TEMA 7	GLOMERULONEFRITIS
NEFROPATÍA IGA	Varón mediana edad con brotes de hematuria macroscópica inmediatamente tras infección respiratoria/digestiva/ejercicio. Complemento NORMAL. Función renal NORMAL.
GMN MEMBRANOSA	Varón 40-50 a + SD nefrótico. SPIKES
GMN POSTESTREPTOCÓCICA	Varón 5-12ª /Diabético > 60 a Sd Nefritico con descenso de C3 tras faringitis aguda/infección cutánea con periodo de latencia 1-3/3-6sem). HUMPS
GMN CAMBIOS MÍNIMOS	Niño <8 a + SD NEFRÓTICO + Complemento normal Ausencia de depósitos IF Complemento NORMAL Fusión pedicelar Ant: alergia/linfoma.
GMN GEFS	Síndrome nefrótico ATÍPICO con <u>IR</u> <u>OBESIDAD /HEROÍNA/VIH/SARS COV2</u> Raza afroamericana SINEQUIAS.
GMN MP TIPO I	Síndrome nefrótico impuro. Hipocomplementemia C3 Y C4 (clásica). Asocia: VHC/gammapatía monoclonal/ Puede tener igM. ASA DE ALAMBRE //DOBLE CONTORNO/RAIL DE TREN.

GMN MP TIPO III	Sd nefrótico impuro en mujer. Hipocomplementemia C3 (alterna). RISTRAS DE CHORIZO.
TEMA 8	AFECCIÓN RENAL DE ENF SISTEMICAS
SD GOODPASTURE	Paciente <30 a + Insuficiencia renal + hematuria + proteinuria + hemorragias alveolares o paciente mayor únicamente con clínica renal. Ac ANTI-MBG lineal.
SD ALPORT	Paciente con afectación renal + sordo + afectación ocular + antecedentes familiares de ERC. Biopsia: MBG HOJAS DE HOJALDRE /LAMINADA.
NEFROPATÍA MEMBRANOSA BASAL FINA	Hematuria + historia familiar de hematuria "La prima hermana buena de Alport".
MIELOMA MÚLTIPLE	Paciente con dolor óseo lumbar + anemia + hipercalcemia + IR.
AMILOIDOSIS	Paciente con SD nefrótico + Enf. inflamatoria crónica.
FABRY	Paciente joven + ictus/infarto muy precoz y fallo renal Hipersudoración, telangiectasia, angioqueratomas. CAPAS DE CEBOLLA.
VASCULITIS (LO COMÚN DE LAS TRES SIGUIENTES)	ANCA (+) + SD. constitucional + GNRP III (IFD-) + SD Renopulmonar + Alteración vía alterna del complemento.
- PAM	Paciente añoso, AC anti-MPO+.
- GPA	Paciente joven, Anti MPR3+, Granulomas cavitados.
- GEPA	Paciente joven, AC anti-MPO(+) + eosinofilia + endogranulomas cavitados.
TEMA 9	MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS
MAT	Anemia hemolítica + trombocitopenia + FRA. CAPAS DE CEBOLLA.
TEMA 10	NEFROPATÍA DIABÉTICA
NEFROPATÍA DIABÉTICA	Diabético de >8 años de evolución + SD. Nefrótico. CELULAS ARMANI EBSTEIN. LESIÓN DE KIMMELSTIEL-WILSON. NECROSIS PAPILAR.

TEMA 11	PATOLOGÍA TUBULAR
NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA	Antecedente de fármaco + FRA + fiebre + RASH + artralgias + dolor lumbar alto.
SD LIDDLE	Niño HTA + alcalosis hipok.
DIABETES INSÍPIDA	- Poliuria + Polidipsia + Orinas hipotónicas.
TEMA 12	ENFERMEDAD POLIQUISTICA
EPQA	Riñones muy aumentados de tamaño + poliglobulia + insuficiencia renal + HTA + Manifestaciones extrarrenales.
TEMA 13	HTA Y RIÑÓN, ENF VASC RENALES
EMBOLISMO RENAL	Dolor lumbar cólico brusco en fosa renal + hematuria + AP: FA
TROMBOSIS VENA RENAL	Dolor lumbar cólico brusco en fosa renal + hematuria + <u>proteinuria intensa + varicocele izquierdo</u> (si es vena renal izquierda).
ATEROEMBOLISMO DE COLESTEROL	>50 años + FRCV (muy arteriosclerótico) + Sometido a un intervencionismo endovascular (cateterismo/cirugía cardiaca/ aórtica) O Anticoagulantes crónicos... que comienza con FRA + pies negros (livedo reticularis). <u>Pulso periférico conservado</u> Otras: <u>hipocomplementemia/eosinofiluria/eosinofilia.</u> ÉMBOLOS DE COLESTEROL (PLACAS DE HOLLENHORST
HTA RENOVASCULAR	HTA de difícil control , con inicio brusco, sin historia familiar de HTA + alcalosis metabólica + hipopotasemia o deterioro de función renal / caía de >50 mmHg de PAS tras tto IECA/ARA II.
NEFROANGIOESCLEROSIS	HTA MALIGNA + Afroamericano + MAT + retinopatía HTA (hemorragias en llamas) NECROSIS FIBRINOIDE //CAPAS DE CEBOLLA

NEUMOLOGÍA

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
SÍNDROME DE BLESOVSKY	Atelectasia redonda en asbestosis.
MIOPATÍA Y/O POLINEUROPATÍA DEL PACIENTE CRÍTICO.	Adulto que ha sufrido una neumonía por COVID 19 que ha necesitado intubación con ventilación mecánica en UCI , y comienza con déficit motor en las 4 extremidades con hiporreflexia generalizada.
TEMA 8	ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES
HISTIOCITOSIS X	Varón + disnea + tos seca + neumotórax Aumento de macrófagos alveolares y células de Langerhans Marcador: okkt6 Gránulos de Birbeck en raqueta de tenis
LINFAGIOLEIOMIOMATOSIS	Patología intersticial con volúmenes conservados y puede aparecer con patrón obstructivo y/o restrictivo. *Es exclusiva de mujeres. * Cursa con neumotórax y quilotórax de repetición.
TEMA 13	SARCOIDOSIS
SD DE HEERFORDT	FIEBRE + PAROTIDITIS BILATERAL + UVEITIS ANTERIOR + PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICO.
TEMA 16	ENFERMEDADES DE LA PLEURA
NEUMOTÓRAX	paciente joven alto, no obeso, fumador con dolor en hemitórax, disnea e insuficiencia respiratoria.
TEMA 18	NEOPLASIAS PULMONARES
TUMOR DE PANCOAST	CLÍNICA: Dolor torácico y cervicobraquial, miosis y enoftalmos unilateral. RX TÓRAX: opacidad en vértice pulmonar y erosión de las primeras costillas.

NEUROLOGÍA

TEMA 1	INTRODUCCIÓN
HIDROCEFALIA NORMOTENSIVA LESION FRONTAL BILATERAL	Apraxia de la marcha + incontinencia urinaria + demencia.
SD DE ANTON " EL POBRE ANTÓN ESTA CIEGO Y NO LO VE"	Ceguera cortical completa y niega su ceguera.
SD DE BALINT "NO MIRA ADONDE LE DIGO"	Apraxia ocular.
SIRINGOMIELIA	Acorchamiento de las manos no nota que se corta ni que se quema.
SÍNDROME DEL UNO Y MEDIO DE FISHER	Pérdida de todos los movimientos horizontales del ojo afecto y la aducción del sano (sólo le queda la abducción, que realiza con nistagmo). Se debe a lesión en la protuberancia (tumor, EM) que afecta: FLM+VI par +/- sustancia reticular pontina.
SD DE BALINT	Ataxia óptica (falta de coordinación entre el input visual y el movimiento de las manos ej. no puede alcanzar algo con la mano) + Apraxia oculomotora (dificultad para dirigir voluntariamente la mirada horizontal ej. mirar a un lado y a otro a la orden)+ Simultagnosia (incapacidad de identificar estímulos visuales simultáneos; ej. <i>ven la H de la figura pero no que está formada por Ts</i>)
SÍNDROME DE ANTON	Ceguera cortical + anosognosia visual
SÍNDROME CANVAS	- <u>C</u> erebellar <u>A</u> taxia (ataxia cerebelosa) - <u>N</u> europathy (neuropatía sensitiva) - <u>V</u> estibular <u>A</u> rreflexia (arreflexia vestibular ipsilateral) <u>S</u> yndrome
SD DE WALLEMBERG	- Vértigo. - Falta de sensibilidad de la mitad ipsilateral de la cara y de las extremidades contralaterales. - Disfonía. - Disartria. - Disfagia. - Síndrome de Horner ipsilateral. NO CLÍNICA MOTORA
TEMA 2	DEMENCIAS

DEMENCIA DE CUERPOS DE LEWY	Deterioro cognitivo Frontosubcortical + alucinaciones visuales + empeoramiento con tto neuroléptico clásicos + parkinsonismo atípico (rigidez bilateral asimétrica con poco temblor).
HIDROCEFALIA NORMOTENSIVA	Apraxia de la marcha + incontinencia urinaria + demencia.
CREUTZFELDT JAKOB	Demencia rápidamente progresiva + alteración del comportamiento, + mioclonías + síntomas piramidales + extrapiramidales + ataxia cerebelosa.
ENFERMEDAD DE PICK (DEMENCIA FRONTOTEMPORAL)	JOVEN (50-60) + ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA + ALTERACIÓN DEL LENGUAJE.
ENFERMEDAD VASCULAR MULTIINFARTO.	Anciano HTA + empeoramiento BRUSCO + curso escalonado + defectos parcheados + signos neurológicos focales.
ENFERMEDAD DE BINSWANGER	Paciente HTA + Aterosclerótico + demencia crónica + leucoaraiosis + demencia subcortical (con marcha típica en pequeños vasos y amplía la base de sustentación parálisis pseudobulbar + signos corticoespinales.
TEMA 4	ICTUS
TROMBOSIS VENOSA	Mujer joven que toma anticonceptivos con HTIC + cefalea + papiledema. TC: SIGNO DEL DELTA VACÍO.
SD VASOCONSTRICCIÓN CEREBRAL REVERSIBLE POSTERIOR	Mujer joven <u>postparto</u> + cefalea holocraneal intensa + náuseas y vómitos + crisis tónico clónicas + hemianopsia homónima izquierda <u>Angio TC/ECG/ANALITICA NORMAL</u> RM: Hiperintensidad en T2 y flair. Resolución en seis meses.
ANGIOPATÍA CONGÓFILA	Hemorragia <u>lobar (superficial) espontánea + recurrente</u> en un anciano no hipertensivo.
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	La cefalea más fuerte de mi vida + náuseas /vómitos/ fotofobia/rigidez nuchal con una cefalea centinela relacionada con maniobras de Valsalva.
ENFERMEDAD DE CADASIL (ARTERIOPATÍA AUTOSÓMICA DOMINANTE CON INFARTOS SUBCORTICALES Y LEUCOENCEFALOPATÍA)	Persona joven + depresión + demencia precoz + migraña + crisis convulsivas. RM: Polos temporales, anteriores, cápsula externa y protuberancia AD: NOTCH3 (CR 19)

SÍNDROME DE PERCHERÓN	Oclusión de la arteria de Percherón (rama de P1, precomunicante), que condiciona un infarto talámico medial . Si la oclusión es bilateral, el infarto talámico será también bilateral cursando con bajo nivel de conciencia .
TEMA 5	TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO
TEMBLOR ESENCIAL	Temblo postural bilateral (mantiene cierta asimetría) + progresivo+ mejora con el alcohol + AF. familiares.
COREA DE HUNTINGTON	Corea + clínica psiquiátrica + deterioro cognitivo (demencia).
PARKINSON	Varón de 50-70 años con BRADICINESIA (SIEMPRE) + temblor de reposo ASIMÉTRICO en miembros superiores + rigidez en tubo de plomo (todo el recorrido) Buena respuesta a L-DOPA.
PARKINSONISMO PLUS	NO hay mejoría con L DOPA + RIGIDEZ SIMÉTRICA + NO HAY TEMBLOR .
PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA	Caídas hacia atrás + no puede mirar hacia abajo + demencia precoz + disfagia y disartria.
AMS	Hipotensión arterial + disautonomía precoz + mucha ataxia.
ENFERMEDAD DE WILSON	Paciente joven <30-40 años + temblor (parkinsonismo) + patología psiquiátrica Anillo de kayser fleisher. Niveles bajo de ceruloplasmina y aumento del hierro
HALLERVORDEN-SPATZ	Adolescente + demencia + corea RM: Ojos de tigre (depósito de hierro en ganglios de la base).

SD DE PIERNAS INQUIETAS (PANTOTENATO QUINASA)	Mujer mayor con disestesias de miembros inferiores sobre todo en reposo con claro predominio por la noche y se alivia al moverlos .
SD DE PANDAS	TICS y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) Causa: una infección por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A.
TEMA 6	ENFERMEDADES DE LA MIELINA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE	Mujer joven + escotoma centrocecal + dolor con la movilización ocular (neuritis óptica) Preguntan mucho: parálisis facial + afectación de la vía piramidal + del VI par + disautonomía (EL MEÓN) SIGNO DE LHERMITTE.
ENFERMEDAD DE DEVIC	>40 AÑOS CON Mielitis (afectación de más de 3 segmentos) CERVICALES + neuritis óptica BILATERAL. AC: AC ANTI ACUAPORINA 4. LCR: >50 CÉLULAS.
NEUROMIELITIS ÓPTICA ANTI MOG	Infancia o adulto joven con antecedente vacunal /infección que tiene una neuritis óptica bilateral en la RM se ven lesiones pseudotumorales diseminada y afectación medular longitudinalmente extensa a nivel del cono medular (afectación debilidad distal en los pies con ausencia del reflejo Aquileo y presencia del reflejo rotuliano). AC ANTI MOG.
MIELINOLISIS CENTRAL PONTINA	Corrección rápida de hiponatremia (afecta al TCE).
ENFERMEDAD DE BALO	Enfermedad desmielinizante monofásica de mal pronóstico. Es adquirida. Se producen áreas concéntricas de desmielinización en la sustancia blanca subcortical
MIELOSIS FUNICULAR	Hombre de 65 años con astenia progresiva y sensación de hormigueo en manos y pies. Presenta tez amarillenta y disminución de sensibilidad vibratoria y posicional en zonas distales . <u>HEMOGRAMA:</u> VCM 120 fl con anisocitosis.
TEMA 7	EPILEPSIAS
ENCEFALITIS AUTOINMUNE	Paciente joven + clínica psiquiátrica + deterioro cognitivo <u>LCR y suero de ac autoinmunes.</u>
ESCLEROSIS MESIAL TEMPORAL	<u>Crisis focal del lóbulo temporal:</u> olor desagradable + automatismos + aura epigástrica + AP: crisis mioclónicas matutinas.

EPILEPSIA MIOCLÓNICA JUVENIL	Convulsiones tónico-clónicas generalizadas matutinas + en privación de sueño/ alcohol .
SÍNCOPE CONVULSIVO	Joven + pródromos + escape de orina + recuperación rápida + dura poco tiempo .
EPILEPSIA ROLANDICA (Epilepsia de la infancia con puntas centrotemporales)	Crisis focales durante el sueño (morfeicas) normalmente motoras peribucuales que se autolimitan en la infancia. No suele requerir tratamiento
TEMA 8	ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO
ELA	Varón 50-60 años con debilidad muscular progresiva de inicio asimétrico , afecta pares craneales bajos (disfagia y disartria) y no afecta a la musculatura extraocular ni esfínter. Clínica de 1 MTN (Babinski +) y 2MTN (amiotrofia) RESPETA OJOS, ESFÍNTER Y SENSIBILIDAD.
ATAXIA DE FRIEDREICH	Varón joven con signos de 1 MTN y 2MTN con afectación de la sensibilidad protopática y ataxia sensitiva + síntomas cerebelosos . <u>Asocia:</u> diabetes mellitus, pie cavo, miocardiopatía hipertrófica y cifoescoliosis.
TEMA 9	ENFERMEDADES VIRALES
ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB	Demencia rápidamente progresiva con alteración del comportamiento + mioclonías + ataxia cerebelosa con síntomas piramidales y extrapiramidales.
ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS	Pacientes jóvenes y predominio de clínica psiquiátrica y la ataxia más que la demencia y mioclonías.
ENCEFALITIS AUTOINMUNE	Paciente joven con clínica psiquiátrica y crisis epiléptica resistente al tto: - Ac intracelular AC anti-GAP 65: epilepsia refractaria y sd de la persona rígida. - AC superficie: • LGI1: Deterioro cognitivo y crisis fasciobraquial distónicas. • NMDA: mujer con teratoma ovárico. • DPPX: DIARREA.
TEMA 10	ENFERMEDADES NUTRICIONALES
ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE	Alcohólica/ malnutrida/hiperémesis gravídica en embarazo que desarrolla: - Oftalmoparesia □ ataxia □ SD. confusional. SD. de Korsakoff: amnesia anterógrada (no puede recordar)

	las cosas recientes).
DEGENERACIÓN SUBAGUDA COMBINADA/MIELINOLISIS FUNICULAR	Paciente alcohólico o gastrectomizado con Anemia megaloblástica + SD. medular posterolateral: - 1º MTN y alteración de la sensibilidad epicrítica/profunda.
PELAGRA (LAS 3D)	Dermatitis bilateral y simétrica en áreas expuestas fotoexpuestas + diarrea y demencia.
ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO ISQUÉMICA	<i>SI NO HAY O2 AC-AB-Amos EXTRA VER-DES</i> Parada cardiorrespiratoria +: - Ataxia cerebelosa + agnosia visual + amnesia anterógrada + extrapiridalismo + vegetalismo (disautonomía) + demencia.
SD GUILLAIN BARRE	Varón joven con ap. de infección respiratoria/digestiva que empieza con: Pérdida de fuerza progresiva en miembros inferiores, arreflexia y parestesias en plantas. Es simétrica y ascendente en menos de 4 semanas. SD autonómicos: hipo/hipertensión/ arritmias LCR: Albúmina > celular Electroneurografia: ausencias de las ondas F.

SD MILLER FISHER	Oftalmoplejía + ataxia + arreflexia y ac antiGQ1B
TEMA 12	PLACA MOTORA
MIASTENIA GRAVIS	Mujer joven con fatigabilidad ocular o musculatura proximal que empeora con el ejercicio y por la tarde . Mejora con el descanso NO alteración reflejo/disautonomía/ reflejo pupilar.
EATON LAMBERT	Varón 40 años con ca microcítico de pulmón y comienza con debilidad muscular. Disminución del reflejo pupilar y de los reflejos. Boca seca Mejora con el ejercicio.
BOTULISMO	Debilidad descendente de manera progresiva y bilateral (de cara para abajo). Hay afectación pupilar. AP: ingesta de alimentos / heridas.
TEMA 13	MIOPATÍA
STEINERT (AD—TRIPLE. CTG)	Varón joven que asocia ptosis bilateral y debilidad en la musculatura del cuello y extremidades distales. Dificultad para la relajación (lengua, mano y párpados). Empeora con el frío y mejora con ejercicio. Expansión de trinucleótidos del gen DMPK.
ENFERMEDAD DE RICKER O DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO II	Expansiones de trinucleótidos del gen ZNF9 o CNBP (son el mismo gen).
ESPONDILOSIS CERVICAL	Anciano + signo de Lhermitte.
WERNICKE	Malnutrido (anciano, cáncer, embarazada) empieza con oftalmoparesia (Visión doble, VI par), afectación de la marcha y síndrome confusional.
DISTROFIA FACIOESCAPULOHUMERAL (FSHD)	Enfermedad hereditaria autosómica dominante. Afecta de manera precoz a la cara + cintura escapular (trapecio, latissimus dorsi y pectoral mayor). No afecta a la esperanza de vida de la mayoría de pacientes.
TEMA 14	CEFALEAS
MIGRAÑA	Mujer joven con dolor hemicraneal pulsátil + incapacitante + sonofobia + osmofobia + fotofobia + aumenta con el esfuerzo + náuseas y vómitos.

CLUSTER	Hombre joven con dolor hemicraneal periocular intenso + congestión nasal + lagrimeo + horner ipsilateral que empieza por la noche. Empeora con el alcohol.
TEMA 15	HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL
TRIADA DE CUSHING EN LA HTIC CRÓNICA (REHABILITACIÓN)	Respiración alterada HTA (+ constante) Bradicardia.
SD DE HIPERTENSION INTRACRANEAL	Mujer de 30 años obesa + fumadora + anticonceptivos + que tiene una cefalea y vómito de característica no benignas con edema de papila bilateral y diplopía horizontal (afectación del VI par) LCR: un aumento de presión.

TEMA 16	HIDROCEFALIA NORMOTENSIVA
HIDROCEFALIA NORMOTENSIVA HIDROCEFALIA ARREABSORPTIVA	Apraxia de la marcha (Lo + precoz y característico) + incontinencia urinaria + deterioro cognitivo. <u>PL evacuadora</u> : mejora la clínica. <u>Test de infusión de SS es +</u> : aumento de resistencia de salida del LCR.
TEMA 17	TUMORES
GERMINOMA PINEAL.	La tríada: diabetes insípida + precocidad sexual + síndrome de Parinaud . - Síndrome de Parinaud : Conjuntivitis granulomatosa con folículos y adenopatías preauriculares.
TUMORES- AP	MENINGIOMA ☐ CUERPOS DE PSAMOMA METÁSTASIS ☐ CÉLULAS ANAPLÁSICAS ASTROCITOMA PILOCÍTICO ☐ FIBRAS DE ROSENTHAL OLIGODENDROGLIOMA ☐ CÉLULAS EN HUEVO FRITO.
MEDULOBLASTOMA	Tumor del SNC genera metástasis en forma de "siembras intrarraquídeas" se disemina al espacio subaracnoideo, causando <u>metástasis por goteo o "drop metastases"</u> . Es el único que metastatiza fuera del SNC.
TEMA 18	TCE
HEMATOMA EPIDURAL	Varón joven + accidente de tráfico + conmoción cerebral con Pérdida de conciencia + intervalo lúcido + coma de rápida evolución TC: lente biconvexa.
HEMATOMA SUBDURAL AGUDO	Traumatismo de alta energía curso con deterioro de la conciencia de manera progresiva por herniación uncal . TC: Imagen en semiluna hiperdensa.
HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO	Traumatismo banal en una persona mayor / anticoagulada / alcohólica que no recuerda el golpe y empieza con una cefalea y demencia progresiva y que fluctúa , TC: imagen en semiluna hipodensa.
LESIÓN AXONAL DIFUSA	Importante disminución de conciencia tras TCE (aceleración-desaceleración ej accidente de tráfico) y mantenido (misma puntuación en la escala de Glasgow), y en el TC no se ve nada (sin hallazgos relevantes) .

FX BASE CRÁNEO	Paciente con TCE y: hemotimpano, equimosis retroauricular, ojos de mapache, parálisis facial, otorrea, otolicuorrea, hipoacusia, vértigo.
SD DEL REFINADO	Tras una craniectomía el paciente empieza con trastornos motores, lenguaje y cognitiva. Hay hundimiento en la zona .
TEMA 19	ABSCESO CEREBRAL
ABSCESO CEREBRAL	Paciente con cefalea + focalidad neurológica (ej crisis epiléptica) y fiebre . MIRAR AP: INFECCIÓN PULMONAR (Adultos) y TETRALOGÍA DE FALLOT (En niños).
EMPIEMA SUBDURAL	Paciente con sinusitis frontal/ etmoidal que comienza con fiebre + cefalea + signos meníngeos y focalidad neurológica unilateral .

TEMA 20	PATOLOGIA RAQUIMEDULAR
MIELOPATÍA CERVICAL	Espondilosis cervical con dolor cervical irradiado a miembros superiores, parestesias en las manos y síntomas de 2 MTN en miembros superiores CON piramidalismo en miembros inferiores por lesión de 1 MTN.
SD DEL CONO MEDULAR	Debilidad muscular bilateral y simétrica de predominio distal (piecitos) con reflejo aquileo abolido y persistencia del reflejo rotuliano .
ANTI-MOG	NIÑO CON AP DE VACUNACIÓN QUE EMPIEZA CON SD DEL CONO MEDULAR: Debilidad muscular bilateral y simétrica de predominio distal (piecitos) con reflejo aquileo abolido y persistencia del reflejo rotuliano.
ESTENOSIS DEL CANAL MEDULAR	Varón anciano que presenta dolor lumbar y lumbociática bilateral, dificultad de miembros inferiores con parestesias . Se tiene que parar cuando camina . Cede en reposo lentamente Y el dolor se alivia a la FLEXIÓN DEL TRONCO HACIA DELANTE. LIMITADA LA FLEXO EXTENSIÓN DE LA COLUMNA
TEMA 21	ANOMALÍAS DEL DESARROLLO
MALFORMACIÓN DE ARNOLD CHIARI	Mujer aprox de 30 años con cefalea suboccipital que aumenta con las maniobras de Valsalva +/- ataxia NISTAGMO VERTICAL . Puede asociarse a siringomielia (nivel suspendido con disociación sensitiva a nivel de miembros superiores) .
TEMA 22	NEUROCIRUGIA FUNCIONAL
NEURALGIA DEL TRIGÉMINO	<u>Mujeres mayores con dolor unilateral de la cara de carácter episódico, de corta duración y lancinante muy incapacitante</u> que se relaciona con actividades como bostezo, masticación, roce. Las zonas afectadas son V2 y V3. Exploración neurológica normal . NO: - NO despierta por la noche. - No focalidad neurológica. (no hipoestesias ni alteración del reflejo corneal). - NO dolor retroauricular ni cervical. - NO síntomas trigeminoautómicos.
OTROS	

SD VASOCONSTRICCIÓN CEREBRAL REVERSIBLE POSTERIOR	Mujer joven, postparto empieza con cefalea holocraneal intensa + náuseas y vómitos. Cifras de TA muy elevadas. Crisis epilépticas y hemianopsia homónima izq /derecha. Analaitia, ECG, ANGIO TC normales. RM: lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR.
---	--

NARCOLEPSIA	Cataplejía (pérdida de tono con las emociones) + episodios de parálisis del sueño del despertar + hipersomnolencia diurna. Estudio dx: - Test de latencias múltiples de sueño. - Polisomnografía nocturna. - Punción lumbar niveles de orexina/hipocretina. - Genética HLA DQB1 0601 y 0602.
TRASTORNO DE LA CONDUCTA DEL SUEÑO REM	Parasomnia con episodios de excesiva motricidad en diferentes grupos musculares durante el sueño REM + actividad onírica de carácter desagradable. <u>DX registro polisomnográfica:</u> ausencia de atonía muscular en esta fase. Manifestación precoz de enfermedades neurodegenerativas (enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica).

PSIQUIATRÍA

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 1	TRASTORNOS NEUROTICOS
CRISIS DE ANGUSTIA /TRASTORNO DE PÁNICO	Mujer joven que presenta <u>crisis repentinas y recurrentes de ansiedad con palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de ahogo y dolor torácico.</u>
AGORAFOBIA	Sentir miedo en algunas situaciones (ir en metro) porque se siente desamparado y piensa que le va a pasar algo y no va a poder pedir ayuda. Miedo desproporcionado a una situación.
FOBIA SOCIAL DE EJECUCIÓN	El paciente se pone malísimo cuando piensa/hacer alguna actividad en público.
TRASTORNO SOMATOMORFOS	Paciente con muchos síntomas , pero sin base médica, es decir, exploración y pruebas complementarias normales.
TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL	Paciente joven (20-30 años) que se queja de algún defecto estético que para él es muy notorio y exagerado , suele consultar a muchos cirujanos , y estos les dicen que no ven tal complejidad.
TRASTORNO CONVERSIVO	Tras un hecho estresante , el paciente presenta síntomas neurológicos con una exploración totalmente normal . Suelen no entender la preocupación del resto ante su situación (indiferencia emocional).
TEMA 3	TRASTORNOS PSICOTICOS

DELIRIO DE CAPGRAS	Los conocidos son sustituidos por dobles que quieren dañarle.
DELIRIO DE FREGOLI	un perseguidor se camufla como distintas personas de su entorno.
TEMA 4	TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS
SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA ALCOHÓLICA	Clínica típica: Hiperactividad autonómica + Temblor distal de las manos + Insomnio + Náuseas o vómitos + Alucinaciones visuales (zoopsias) + Agitación psicomotriz + Ansiedad + Crisis comiciales.
TEMA 5	TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS
SÍNDROME DE GANSER	Pseudodemencia disociativa. Se producen síntomas psiquiátricos graves que recuerdan a una demencia. Se describió en <u>gran estrés, como los presos del holocausto</u>
TEMA 6	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
ANOREXIA NERVIOSA TIPO RESTRICTIVO	Combinación de adelgazamiento voluntario excesivo con práctica compulsiva de ejercicio .
ANOREXIA NERVIOSA TIPO PURGATIVO	Pacientes que comen vorazmente de modo intermitente pero luego tratan de eliminar las calorías con vómitos o consumo de laxantes .
TEMA 8	TRASTORNOS DEL SUEÑO
SD KLEINE LEVIN /HIPERSOMNIA ASOCIADA A LA MENSTRUACIÓN	Kleine Levin: varón con hipersomnias recurrentes que dura días + hiperfagia (come mucho) + alteraciones psicopatológicas (conducta sexual anormal /alucinaciones / síntomas afectivos) Dura semanas y tal cual viene, se va BUEN PRONÓSTICO . LITIO
NARCOLEPSIA	Personas hipersomnolencia + cataplejía con las emociones (atonía muscular) + parálisis del sueño + alucinaciones visuales

PEDIATRÍA

TEMA 1	NEONATOLOGÍA
HEMORRAGIA INTRACRANEAL	Prematuro que de manera súbita tiene hipotensión + anemia + abombamiento de fontanela .
ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA	RN A término con convulsiones tras un evento centinela que ha precisado reanimación - apgar <5 o ph < 7 .
COARTACIÓN DE AORTA	Soplo disminuido y disminución de pulso femoral.
TROMBOSIS DE VENA RENAL	Masa sólida en abdomen + HTA + hematuria + trombopenia + deshidratación + policitemia + hijo de madre diabética.
HEMORRAGIA SUPRARRENAL	RN macrosómico que ha tenido un parto de nalgas y tiene Hiponatremia, hiperpotasemia e hiperglucemia.
SD DE BECKWITH-WIEDEMAN	Onfalocele, macroglosia, hemihipertrofia, visceromegalias, e hipoglucemia por hipertrofia de los islotes pancreáticos.
TAQUIPNEA TRANSITORIA /PULMÓN HUMEDO/MALADAPTACION PULMONAR	Neonato a término nacido por cesárea o parto vaginal rápido que presenta dificultad respiratoria inmediata y que mejora con oxígeno . RX: Con líquido en la cisura.
ENFERMEDAD DE LA MEMBRANA HIALINA	Recién nacido prematuro, hijo de madre diabética que presenta dificultad respiratoria grave que es refractaria al tto de oxígeno . Rx: broncograma aéreo y patrón reticulonodular.
SD DE ASPIRACION MECONIAL	Recién nacido postérmino que ha tenido sufrimiento fetal y está pálido, hipotónico, apneico y líquido verdoso. RX: hiperinsuflación pulmonar + infiltrados alveolares
DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE	RN pretérmino con EMH que tiene un soplo sistólico o continuo en zona subclavicular izquierdo y hepato esplenomegalia . RX: edema pulmonar y cardiomegalia. DX eco doppler.
PERSISTENCIA DE CIRCULACIÓN PULMONAR	RN postérmino con síndrome de aspiración meconial que está muy hipoxémico pero su rx es normal . La saturación de O ₂ pre y post ductal hay una diferencia del 10% y en la gasometría arterial una diferencia de más de 20 mmHg

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE	RN prematuro que a las dos o tres semanas comienza con DISTENSIÓN ABDOMINAL (primer signo) + VÓMITOS + DOLOR ABDOMINAL Y HECES SANGUINOLENTAS . RX: + TÍPICO NEUMATOSIS INTESTINAL.
SD DE ALAGILLE (MUTACIONES DE NOVO > AD)	Ictericia a costa de bilirrubina directa . Fenotipo: cara de pájaro, vértebras en mariposa, malformaciones renales y oculares (embriotoxon posterior)
STURGE-WEBER	Facomatosis no hereditaria con mancha de vino de oporto en V1-V2 . Puede manifestarse con epilepsia debido a la presencia de un angioma leptomeníngeo localizados en coroides y conjuntiva.
SÍNDROME DE WAARDENBURG O ENFERMEDAD DE LOS OJOS AZULES	Se asocia a la enfermedad de Hirschsprung - Además, la enfermedad de Hirschsprung se asocia en un 50% de casos a mutación del protooncogén RET .
SÍNDROME DE KINSBOURNE	Opsoclonus-mioclonus en el contexto de un neuroblastoma. Anticuerpos: Anti-Hu
PÉNTADA DE CANTRELL	1) Defecto del esternón inferior 2) Defecto abdominal (onf, gastr) 3) Defecto diafragmático anterior 4) Defecto pericárdico diafragmático 5) Anomalía intracardiaca
TEMA 3	PATOLOGÍA RESPIRATORIA
LARINGOMALACIA	<u>Recién nacido</u> + estridor inspiratorio .
LARINGITIS (VÍRICA/ ESPASMÓDICA)	<u>Niños entre 3m – 5 años</u> con estridor inspiratorio, dificultad respiratoria + tos perruna o metálica . EMPEORA POR LA NOCHE. Laringitis vírica: cuadro catarral previo +/- fiebre Laringitis espasmódica: Estrés, atopia, RGE.
EPIGLOTITIS	<u>Niño entre 2 y 6 años</u> con mal estado general + estridor inspiratorio + voz apagada . Empeora con el llano y en decúbito supino. POSICIÓN DE TRÍPODE. Examen laríngeo: epiglotitis en rojo cereza. RX lateral: "signo del dedo pulgar.

TRAQUEITIS BACTERIANA	Niño de cualquier edad con mal estado general + catarro previo que empeora y comienza con ESTRIDOR MIXTO (INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO) + FIEBRE ELEVADA.
BRONQUIOLITIS	Niño MENOR DE DOS AÑOS con un primer episodio de sibilancias de causa infecciosas. Niño < 2 años con un cuadro de catarro de vías altas que tras 48-72 horas empieza a empeorar con dificultad respiratoria , tos seca, fiebre, rechazo de tomas. EXPLORACIÓN: Sibilancias alargadas, roncus, subcrepitantes + hipoventilación. Espiración alargada. NO TTO FARMACOLOGICO
TOS FERINA	Lactante que tras un cuadro catarral comienza con tos paroxística: cuadros de golpe de tos en metralleta □ congestión nasal y cianosis □ estridor inspiratorio gallo □ agotamiento. Acompaña: vómitos, hemorragias subconjuntivales, prolapso rectal. AS: LINFOCITOSIS BRUTAL ENTRE LAS CRISIS asintomático y afebril

TEMA 4	PATOLOGÍA PEDIÁTRICA DIGESTIVA
ATRESIA DUODENAL	Sd down + vómitos biliosos desde el nacimiento + imagen de la doble burbuja.
ATRESIA DEL PÍLORO	vómitos no biliosos desde el nacimiento + imagen de única burbuja.
ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO	Varón de 21 días de vida, primogénito con clínica de VÓMITOS PROYECTIVOS NO BILIOSOS , Aidez por las tomas y alcalosis hipoclorémica e hipopotasémica.
DIVERTÍCULO DE MECKEL	Niño de dos años con buen estado general , asintomático sin dolor, deposición hemorrágica abundante , y sangre rectal indolora e intermitente .
INVAGINACION INTESTINAL	Niño entre 3 meses- 6 años con crisis de llanto con encogimiento de piernas, vómitos, irritabilidad y deposiciones hemorrágicas (heces en jalea de grosella). ECO: IMAGEN EN DONUT
DIARREA CRÓNICA INTOLERANCIA TRANSITORIA A LA LACTOSA	Niño que tiene como antecedente gastroenteritis aguda que comienza con <u>deposiciones acuosas y ácidas con olor a vinagre</u> . Abdomen meteorizado y ruidos hidroaéreos aumentados y eritema perianal.
ENFERMEDAD CELIACA	NIÑA + DIARREA CRÓNICA + RETRASO PONDERAL.
SD DE REYE	infección viral + AAS □ vómitos bruscos persistentes □ SNC e hígado (encefalopatía hepática e degeneración grasa hepática).
ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA MEDIADA POR IGE	Paciente al que le han dado una segunda toma de leche artificial y que en pocos minutos comienza con clínica cutánea (urticaria-eritema peribucal) , dificultad respiratoria y vómitos.
ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA NO MEDIADA POR IGE	Lactante que empezó con fórmula artificial hace dos semanas y comienza con rectorragia intermitente sin otra clínica.
HERNIA DIAFRAGMÁTICA DE BOCHDALEK	Niño con: - RX tórax: áreas circulares en tórax izquierdo. - Abdomen excavado - Latido cardíaco desviado a la derecha
TEMA 5	PATOLOGÍA NEFROUROLÓGICA
TORSIÓN TESTICULAR	Niño aprox 12 años con dolor agudo intenso testicular + cortejo vegetativo (vómitos y dolor abdominal) EF: TESTE indurado + edematoso + eritema escrotal y aumentado de tamaño REFLEJO CREMASTÉRICO NEGATIVO SIGNO DE PREHN NEGATIVO

TORSIÓN HIDÁTIDE	Niño aprox de 8 años con dolor agudo leve + buen estado general + sin otra clínica. EF: dolor en el polo superior del teste + mancha azul REFLEJO CREMASTÉRICO POSITIVO.
EPIDIDIMITIS	Niño con dolor de testes + fiebre y sd miccional. REFLEJO CREMASTÉRICO ES POSITIVO. SIGNO DE PREHN POSITIVO.
TEMA 6	ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
NEUROBLASTOMA	Niños de dos años con una masa abdominal que cruza la línea media y con síntomas acompañantes: hepatomegalia, diarrea secretora, HTA, taquicardia y opsoclono- mioclono (kinsbourne-movimientos raros con los ojos). OJOS DE MAPACHE Sd de pepper: neuroblastoma y hepatomegalia
NEFROBLASTOMA /WILMS	Niño de más de 3 años con una masa abdominal que NO cruza línea media. Niño asintomático (hallazgo casual), hemihipertrofia, aniridia, sd beckwith wiedemann.
TEMA 7	ENFERMEDADES INFECCIOSAS
SEXTA ENFERMEDAD (ERITEMA SÚBITO)	Lactante con fiebre alta durante 3 días y buen estado general, desaparece la fiebre y aparece un exantema limitado al tronco y extremidades (proximal)
QUINTA ENFERMEDAD (ERITEMA INFECCIOSO)	5 años con exantema (eritema en las mejillas BOFETÓN) □ Exantema generalizado que aclara por el centro y queda en eritema de encaje
ESCARLATINA	5-15 años con fiebre y odinofagia intensa que RESPETA EL TRIÁNGULO NASOGENIANO. Se acumula en los pliegues (línea de pastia) y se palpa mejor que se ve.
RUBEOLA	Cuadro exantemático agudo asociado a síndrome febril + poliadenopatías, SIN faringitis asociada NI H-Esplenomegalia con principal complicación de poliartritis.
SARAMPIÓN	Cuadro agudo grave con síndrome febril, asociado a exantema generalizado morbiliforme + tos + conjuntivitis SIN dolor abdominal NI Hepatoesplenomegalia. MANCHAS DE KOPLIK
ENFERMEDAD DE KAWASAKI	CLÍNICA - Inyección conjuntival bilateral sin exudado. - Eritema de mucosas faríngea y oral con lengua aframbuesada y labios rojos y agrietados. - Edema indurado y eritema de manos y pies. - Exantema polimorfo. - Linfadenopatía cervical no supurativa, generalmente unilateral con un ganglio de >1,5cm.

TEMA 9	MALTRATO INFANTIL
SHAKEN BABY	Niño con hemorragias retinianas, fracturas a distintos niveles, pérdida de tono y adormilado (hematoma subdural).
TEMA 11	METABOLOPATÍAS
PARTE 1	ALTERACIÓN SÍNTESIS/CATABOLISMO DE MOLÉCULAS COMPLEJAS (Progresivas sin debut)
MUCOPOLISACARIDOSIS	Tipo I HURLER (GARGOLISMO) Tipo II (HUNTER) <u>AR LIGADA AL X.</u> TIPO III (san Filippo): agresividad y espasticidad.
ENFERMEDAD DE GAUCHER	Clínica neurológica + dolores óseos + hepatoesplenomegalia + anemia + trombopenia MO: células de gaucher "papel de seda arrugado"
SÍNDROME DE SANFILIPPO	Mucopolisacaridosis por acúmulo intralisosomal de heparán sulfato.

ENFERMEDAD DE NIEMANN PICK	Marcada hepatoesplenomegalia + parálisis de la mirada VERTICAL . Células espumosas.
ENFERMEDAD DE FABRY	Paciente joven con: IAM o fallo ventricular izquierdo ICTUS/AIT HTA/PROTEINURIA/INSUFICIENCIA RENAL TRIADA: ACROPARESTESIAS + HIPOHIDROSIS + ANGIOQUERATOMAS Hipohidrosis □ intolerancia al ejercicio.
ENFERMEDAD DE TAY SACH	Cabezones + mancha rojo cereza + hiperacusia. (reacción de sobresalto exagerado)
ENFERMEDAD DE WOLMAN	Calcificación de las glándulas suprarrenales.
ENFERMEDAD DE GAUCHER	AR ("gaucher"), - Déficit de Beta-glucocerebrosidasa o Beta-glucosidasa que produce un acúmulo de glucocerebrósidos (glucosilceramida), que ocurre en hígado, bazo y médula ósea (causando mieloptisis) -TTO: enzima recombinante (imiGLUCERasa) Es la esfingolipidosis más frecuente
PARTE 2	INTOXICACIONES AZÚCARES
GALACTOSEMIA	HIPOGLUCEMIA + CATARATAS BILATERALES + HEPATOMEGALIA + RETRASO PSICOMOTOR.
FRUCTOSEMIA	Agudo: fallo hepático + shock + hipoglucemia Crónico: fallo de medro + tubulopatía + hepatomegalia.
ACIDEMIA ORGÁNICA / CICLO DE LA UREA	ACIDOSIS METABÓLICA CON ANION GAP AUMENTADO CON HIPERAMONEMIA Y CETONURIA.
PARTE 3	GLUCOGENOSIS
VON GIERKE (IB HEPÁTICA)	Cara de muñeca + hepatomegalia + HIPOGLUCEMIA CON AUMENTO DEL ÁCIDO LÁCTICO + ÁCIDO ÚRICO.

OTORRINOLARINGOLOGÍA

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 2	OTOLOGÍA
ZOSTER OTICO (SD DE RAMSAY HUNT)	Parálisis facial periférica (toda hemicara completa) + otalgia + afectación del VIII par (hipoacusia/ vértigo).
OTITIS EXTERNA MALIGNA O NECROTIZANTE	<u>Paciente diabético o inmunodeprimido</u> que tiene otalgia intensa + signo del trago positivo + necrosis+ afectación de pares craneales que no cura con tto habitual <u>Otoscoopia</u> : pólipos, esfacelos.
MIRINGITIS BULLOSA	En una infección respiratoria salen ampollas hemorrágicas dolorosas que cede el dolor cuando se rompe.
OTOTUBARITIS	AP de infección respiratoria + hipoacusia de transmisión + tímpano retraído . Timpanograma : presiones negativas.
OMS	AP de infección respiratoria + hipoacusia de transmisión + tímpano ambarino / azulado. Timpanograma : plano.
MASTOIDITIS	Eritema + borramiento del surco + separa la oreja.
PETROSITIS (GRADENIGO)	Otorrea + dolor retroorbitario (V par) + diplopía (VI) TC o RMN por alto riesgo de infección intracraneal. Trataremos con C3G +/- cirugía.
SD DE VERNET	Afectación de VI Par IX, X, XI <u>EN OTITIS EXTERNA MALIGNA</u> o <u>PARAGANGLIOMA TIMPÁNICO</u> .
SD DE COLLET-SICARD	Afectación del sd de vernet + XII par en <u>OTITIS EXTERNA MALIGNA</u> o <u>PARAGANGLIOMA TIMPÁNICO</u> .
MASTOIDITIS DE BEZOLD	Absceso en la punta de la mastoides entre músculo esternocleidomastoideo y digástrico con tortícolis .
MASTOIDITIS DE MOURET	Absceso entre músculo digástrico y yugular
SIGNO DE JACQUES	Absceso retroauricular y con el pabellón hacia delante
FÍSTULA DE GELLÉ	Fístula a la piel o pared del CAE en una mastoiditis lateral.
TROMBOFLEBITIS DEL SENOSIGMOIDE O LATERAL	SIGNO DE GRIESINGER : Edema y dolor retroorbitario por trombosis de venas emisarias mastoideas.

COLESTEATOMA	OMC + otorrea fétida + perforación timpánica ATICAL /MARGINAL /ANNULUS +/- escamas/perlas /pólipos 1º prueba: TAC PEÑASCO Siempre cirugía.
SÍNDROME DE USHER	Retinosis pigmentaria + sordera congénita

OTOESCLEROSIS	Mujer blanca 20-30 años con hipoacusia de transmisión bilateral progresiva que empeora con los embarazos y con ausencia del reflejo estapedial. AFamiliares. Escotoma de Carhartt 2000HZ. Paracusia de Willis (oyen mejor si mucho ruido). Paracusia de weber (resonancia de propia voz). Otoscoopia: signo de Schwartze : enrojecimiento del promontorio. Timpanograma : normal o disminuido.
PARAGANGLIOMA	Acúfeno unilateral con sincronía con el pulso + masa rojiza pulsátil en el hipotímpano. Signo de Brown (acufeno disminuye al comprimir la arteria carótida interna).
HIPOACUSIA BRUSCA	Hipoacusia unilateral perceptiva, brusca (< 3 días), de más de 30 db y más de 3 frecuencias consecutivas.
SD DE COGAN	Hipoacusia autoinmunitaria neurosensorial bilateral que mejora con corticoides y queratitis intersticial. Hay afectación vestibular (vértigo).
TRAUMA ACÚSTICO	Acúfeno + hipoacusia sensorial + escotoma de 4000 HZ .
SD DE USHER I	Displasia cocleovestibular completa + retinitis pigmentaria.
SD DE WAARDENBURG	Distopia cantorum + heterocromía del iris + nariz ancha + canas.
SD DE REFSUM	Displasia cocleosacular, polineuropatía y ataxia con retinitis pigmentaria.
VERTIGO POSICIONAL PAROXISTICO BENIGNO	Crisis de vértigo de minutos + cortejo vegetativo + corta duración en un anciano.
NEURITIS VESTIBULAR	Ap: infección de vías respiratorias con crisis única de vértigo de varios días.
SD DE MENIERE	Crisis de vértigo de horas de duración repetidamente + acúfenos + sensación de plenitud ótica + pérdida de audición (hipoacusia neurosensorial fluctuante afecta más en graves).
SD DE MERLKERSSON-ROSENTHAL	Parálisis facial periférica recidivante + edema hemifacial.

SD DE HEERDFORT	FIEBRE UVEOPAROTIDEA - Sarcoidosis. - Uveítis anterior. - Fiebre. - Parotiditis bilateral. - Parálisis facial bilateral. - Dacrioadenitis crónica.
PARÁLISIS DE BELL	- Falta de lagrimeo. - Hipogeusia. - Hiperacusia.
TEMA 3	RINOLOGIA
MUCORMICOSIS	Diabético/inmunodeprimido + costras negras en la cara + rinorrea + parálisis de pc (VII-VI, III).
OCENA	Mujeres jóvenes asiáticas con gran cantidad de costras nasales que huelen mal, pero ellas no lo saben.
TRIADA ASA O WIDAL	Asma + intolerancia aine + pólipos bilateral (la cirugía y retirada de pólipos mejora el asma).
PAPILOMA INVERTIDO	Poliposis unilateral que se origina en la pared lateral nasal en el cornete y el meato medio.
OSTEOMA	Varón joven con cefalea en la RX tumor calcificado en SENO FRONTAL.
TUMORES NASOSINUSALES	Insuficiencia respiratoria con RINORREA UNILATERAL PURULENTA + EPISTAXIS <u>Paciente tipo:</u> alguien que trabaja con níquel o madera (carpintero o ebanista).
OSTEOMA	Masa blanca en senos.
CUERPO EXTRAÑO	Niño/ persona con retraso mental presenta una otorrea unilateral purulenta.
SINUSITIS CRÓNICA (KILLIAN)	sinusitis crónica con pólipo unilateral que nace en el seno maxilar en joven.
TEMA 4	CIRUGÍA MAXILOFACIAL
CARCINOMA DE CAVIDAD ORAL	Varón de 60 años <u>fumador, alcohólico</u> con <u>mala higiene dental</u> que tiene una <u>úlcer/lesión blanquecina</u> en la mucosa oral, de bordes mal definidos, adheridas a plano profundos .

DISFUNCION ATM	Mujer de edad media con ansiedad y estrés que comienza con cefaleas, otalgia y bruxismo. Otalgia con otoscopia normal.
GINGIVITIS ULCERO NECROTIZANTE AGUDA	Paciente VIH con grandes úlceras en sacabocados + dolor + hemorragias + olor desagradable + necrosis de papila Tto: metronidazol.

ANGINA DE LUDWIG	Paciente con AP de infección dental/BOCA SÉPTICA con trismus + odinofagia + dificultad para respirar + tumoración del suelo de la boca (submandibular)
AMELOBLASTOMA	Paciente de 30-40 años con imagen radiolúcida multiloculada como si fueran POMPAS DE JABÓN en <u>mandibular posterior</u> .
FX CUELLO MANDIBULAR (SUBCONDÍLEA)	Paciente que recibe un golpe en el mentón con desplazamiento mandibular al lado AFECTO Y mordida abierta del lado CONTRALATERAL.
TEMA 5	PATOLOGÍA DE LA FARINGE
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA	Joven con amigdalitis aguda que no mejora con antibióticos y adenopatías múltiples.
FLEMÓN PERIAMIGDALINO	Amigdalitis que no mejora + otalgia refleja + voz gangosa + trismus.
ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO JUVENIL	Adolescente con epistaxis de repetición + síntomas de adenoiditis (obstrucción nasal, otitis media serosa de repetición).
INFECCIÓN POR VEB (EPSTEIN-BARR)	Adolescente- adulto con tríada clásica de astenia intensa + faringitis y linfadenopatías generalizadas, esplenomegalia y hepatomegalia .
TEMA 6	PATOLOGÍA DE LA FARINGE
SD GERHART	Parálisis de las cuerdas vocales en posición paramediana con fonación conservada
LARINGOMALACIA	Niños menores de 6 meses con un estridor inspiratorio agudo que aumenta con el llanto y en decúbito supino, que va disminuyendo de manera progresiva y desaparece antes del año de vida.
LARINGOCELE	Tosedor crónico o trompetista con tumoración cervical lateral que aumenta con las maniobras de Valsalva y disminuye a la compresión.
TBC LARÍNGEA	Paciente joven y no fumador con disfonía y una lesión de características similares a una lesión cancerosa que NO FIJA LA CUERDA.
PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL BILATERAL DEL NERVIO RECURRENTE	Ap: CIRUGÍA TIROIDEA + estridor
TEMA 7	PATOLOGÍA DE GLÁNDULAS SALIVALES
SIALOLITIASIS	Dolor y tumefacción que empeora tras las comidas

ADENOMA PLEOMORFO

La **señora pleomorfa** bulto firme en la zona de la parótida que no le duele y que crece de manera lenta.

TUMOR DE WARTHIN	EL SEÑOR WARTHIN es un anciano fumador con <u>tumoración quística</u> en la zona de la parótida (cola) que no le duele y que crece lentamente.
SD DE FREY O DEL NERVIO AURICULOTEMPORAL	Ap: parotidectomía Síndrome de las tres H - Hiperhidrosis (me suda mucho la cara) - Hiperestesias (dolor) - Hiperemia (enrojecimiento) <i>" Esta zona se me pone roja, duele y suda cuando como"</i>
TEMA 8	PATOLOGÍA CERVICAL
QUISTE TIROGLOSO	Masa cervical en línea media que asciende con la deglución en un niño . Suele aparecer de manera brusca durante un proceso infeccioso de vías altas.
QUISTE BRANQUIAL	Masa lateral en adolescentes y adultos jóvenes. Suele aparecer de manera brusca durante un proceso infeccioso de vías altas.
PARAGANGLIOMA CAROTÍDEA	Masa lateral en el cuello pulsátil con soplo +/- síntomas compresivos + signo de la FONTAINE (se desplaza lateralmente, pero no vertical).
SIGNO DE HOSER	Dolor en la adenopatía tras <u>la ingesta de alcohol</u> .

TRAUMATOLOGÍA

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 1	FRACTURAS
PARTE 1	GENERALIDADES Y COMPLICACIONES
AUSENCIA DE CONSOLIDACIÓN	Fractura previa con ausencia de consolidación y formación de una “articulación” pasado 6 meses con dolor y movilidad en la zona. Atrófica: hoja de sable. Hipertrófica: pata de elefante.
SD COMPARTIMENTAL	Paciente con fractura (generalmente cerrada) de tibia, antebrazo o codo (supracondílea infantil) que comienza con MUCHO DOLOR que aumenta con el estiramiento pasivo Y una presión compartimental > 30-40 mmHg o una diferencia entre Presión diastólica -presión compartimental < 30 mmHg . Pulsos conservados. Fases avanzadas: alteración de la sensibilidad .
SD COMPARTIMENTAL CRONICO	Deportistas muy musculosos que, al hacer ejercicio , presentan dolor y tienen que parar. Suele afectar a las piernas.
SD DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO O SÍNDROME DE SUDECK	Mujer de mediana edad que refiere dolor quemante e hiperestesia <u>con o sin fractura previa</u> que afecta a muñecas, manos, dedos o tobillo. Suele darse tras un periodo de inmovilización prolongada .
SD DE EMBOLIA GRASA	Paciente con fractura cerrada en miembro inferior (diáfisis del fémur) que NO ha sido estabilizada. El paciente se encontraba bien (intervalo lúcido) y comienza con disnea, taquipnea, SDRA + petequias en tórax, cara y conjuntivas + disminución de conciencia . RX: tormenta de nieve . Analítica: PaO2<60 + Trombopenia + anemia.
PARTE 2	FRACTURAS DE EXTREMIDAD SUPERIOR.
FRACTURA DEL HÚMERO PROXIMAL	Anciano + hematoma en la cara medial del brazo y lateral del tórax (equimosis de Hennequin). OJO NERVIO AXILAR.
FRACTURA DE HOLSTEIN-LEWIS	Fractura <u>oblicua</u> del tercio distal de la diáfisis humeral con NEURAPRAXIA DEL NERVIO RADIAL “MANO CAÍDA O BESA MANO” Tras fractura de la diáfisis del húmero.
FRACTURA DE KOCHER-LORENZ	Fractura de un fragmento osteocondral del cóndilo humeral

FRACTURA DE HAHN STEINTHAL

Fractura de todo el cóndilo humeral

FRACTURA DEL BASTÓN	Fractura de la diáfisis del cúbito en un único punto.
FRACTURA DE LA CABEZA DEL RADIO	Caída sobre la palma de la mano
ESSEX-LOPRESTI	Fractura de la cabeza del radio + luxación radio cubital distal + lesión de la membrana interósea
FRACTURAS DE MONTEGGIA	Fractura de la diáfisis del cúbito proximal + luxación de la cabeza del radio
FRACTURAS DE GALEAZZI	Fractura de la diáfisis del radio distal y luxación de la cabeza del cúbito
FRACTURA DEL RADIO DISTAL	Mujeres postmenopáusicas con osteoporosis que caen con la mano en extensión: - Fractura de colles en supinación + dorsal + radial (<u>deformidad en tenedor</u>) <u>cae en extensión</u> - Fractura de Smith: en volar. <u>deformidad en pala de jardinero.</u> - Fractura de Rhea-Barton: desprende margen dorsal o volar (invertido) + subluxación del carpo. - Fractura de Hutchinson o del chauffeur o del chófer: fractura del estiloides radial.
FRACTURA DEL ESCAFOIDES	Jóvenes que sufren una caída sobre el talón de la mano forzando la extensión con dolor y tumefacción en la tabaquera anatómica.
FRACTURA DE LA BASE DEL PRIMER METACARPIANO	FRACTURA DE BENNET: Intraarticular + desplazada protracción del abductor (separador largo del pulgar). QX FRACTURA DE ROLANDO: intraarticular + conminuta . CONSERVADOR.
FRACTURA DEL BOXEADOR	Fractura del cuello del 5º metacarpiano. CONSERVADOR.
PARTE 3	FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR
FRACTURA DE CADERA	Anciano con acortamiento de extremidad inferior + dolor + impotencia absoluta para andar INTRACAPSULAR: todo menos marcado, abducción menor o posición neutra o aducción sin hematoma EXTRACAPSULAR: Todo super marcado: borde externo del pie tocando la camilla + gran abducción con hematoma.
FRACTURA DE DUPUYTREN	EVERSIÓN DEL PIE + LESIÓN MALÉOLO MEDIAL /LIGAMENTO LATERAL MEDIAL (LIGAMENTO DELTOIDEO) (+ FRACTURA DIAFISIS DE PERONE + LUXACIÓN TOBILLO LATERAL + FRACTURA BIMALEOLAR

FRACTURA DE MAISONNEUVE	EVERSIÓN DEL PIE + LESIÓN MALÉOLO MEDIAL /LIGAMENTO LATERAL MEDIAL (LIGAMENTO DELTOIDEO) + FRACTURA METAFISARIA PROXIMAL DEL PERONÉ
FRACTURA DEL ASTRÁGALO	Fx del aviador
SIGNO DE HAWKINS	Resorción subcondral en el cuerpo del astrágalo: indica buena vascularización y buen pronóstico.
FRACTURA DEL CALCÁNEO	Caída desde altura con traumatismo axilar +/- fracturas <u>vertebrales lumbares o meseta tibial.</u>
FRACTURA DE JONES	Fractura del quinto metatarsiano por inflexión en la unión metafisodiafisaria. Vascularización precaria
TEMA 2	LUXACIONES
LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR	Caída de moto o bici con dolor local en el hombro: - Lesión de los ligamentos acromioclavicular: dificultad para el movimiento AP e inestabilidad horizontal - Lesión de los lig acromioclaviculares + coracoclaviculares: descenso de la escápula + dolor local + inestabilidad horizontal y vertical + signo de la tecla del piano.
LUXACIÓN GLENOHUMERAL ANTERIOR	Paciente que viene con separación del brazo y rotación externa fija. Deformidad en charretera Dolor con cualquier movimiento. Puede asociar fractura del troquíter y pérdida de sensibilidad de la cara lateral del brazo con dificultad en la abducción (nervio axilar)
LUXACIÓN GLENOHUMERAL POSTERIOR	Paciente con crisis convulsiva o pérdida de conciencia que viene con el brazo pegado y en rotación interna. Presenta dificultad en rotación externa y abducción en > 90º La deformidad es muy sutil. Puede asociar fractura del troquíter y post de glenoides.
LUXACIÓN RECIDIVANTE TRAUMÁTICA	Luxaciones antes traumas o movimientos banales (nadar) Ha tenido una luxación previa por traumatismo y presenta inestabilidad unidireccional (anteroinferior). BANKART: avulsión <u>anteroinferior del</u> labrum y de los lig GH inferiores. HILL-SACHS: Impactación <u>posterolateral</u> de la cabeza femoral.

LUXACION RECIDIVANTE ATRAUMATICA	Luxaciones antes traumas o movimientos banales (nadar) No trauma previo. Existe hiperlaxitud. Luxaciones con inestabilidad en todos los planos, pudiendo ser voluntarias y bilaterales.
LUXACION POSTERIOR DEL CODO	Caída sobre la extremidad superior. Pérdida del triángulo de NELATON (Equilátero □ escaleno). Asocia fx cabeza del radio, coronoides y olécranon.
LUXACION DEL CARPO (ligamento perilunar).	Luxación por caída con la mano en hiperextensión. Asocia lesión del nervio mediano y fracturas: escafoides /estiloides radial /ambas.
LUXACION DE ROTULA	Mujer de 20 años con rótula alta e hipoplasia del cóndilo femoral lateral.
LUXACION POSTERIOR DE CADERA (+ FREC)	“BAÑISTA” ap: accidente de tráfico con pies en el salpicadero. - Acortamiento del miembro inferior - Flexión, aducción y rotación interna - Ascenso del trocánter. Se palpa en región glútea NERVIO CIATICO. (pie caído).
LUXACIÓN ANTERIOR DE LA CADERA	- Alargamiento del miembro inferior - Rotación externa y abducción. LESIÓN PAQUETE VASCULONERVIOSO FEMORAL.
LUXACION DE RODILLA	Traumatismo de alta energía agudo con inestabilidad multidireccional de rodilla. OJO CON LA ARTERIA POPLÍTEA □ TROMBOSIS ARTERIAL AGUDA Y NERVIO PERONEO.
LUXACION DE LISFRANC	Accidente de tráfico/ pisar mal el borde de una acera/ equitación. Luxación tarso-metatarsiana. <u>Inestable □ qx con agujas.</u> Pasar desapercibida: se nota sobre todo en la alineación de los mtt 2º y 4º.
LUXACION DE CHOPART	Accidente de tráfico /accidente deportivo. Luxación calcáneo- cuboides y astrágalo escafoides. <u>Inestable □ reducción cerrada e inmovilización.</u>
TEMA 3	LESIONES TRAUMÁTICAS E INFLAMATORIAS DE PARTES BLANDAS
PULGAR DEL ESQUIADOR O DEL GUARDABOSQUES	Un accidente de esquí donde hay una separación forzada del primer dedo y no puede hacer pinza con el primer dedo y el segundo.

LESIÓN DE STEINERT	Interposición de la aponeurosis aproximador corto en el pulgar del esquiador.
LESIÓN MENISCAL	Giro con rodilla en flexión y cargada □ derrame sinovial a los 18-24h □ bloqueos en flexión y en rotación de la rodilla.
TRIADA DESGRACIADA DE O'DONOGHUE	LCA + Ligamento colateral medial + menisco medial (si la tienes a la CA-MI-LLI- TA)
LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL	Accidente jugando al fútbol o esquí. No derrame Mecanismo: <u>valgo forzado</u> .
LIGAMENTO COLATERAL LATERAL	Varo forzado y sin derrame + avulsión del peroné.
FRACTURA DE SEGOND	LCA + avulsión del margen tibial anterolateral + menisco medial
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	Hiperextensión de la rodilla + giro + valgo Chasquido + hemartros + desplazamiento de la tibia hacia delante Inestabilidad en valgo (LACHMAN + y cajón anterior +)
LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR	Traumatismo directo en tibi con rodilla en flexión Cajón posterior + (desplaza el fémur por delante) Hiperextensión de la rodilla sin freno.
ESGUINCE DE TOBILLO	Estaba haciendo deporte y se produce una <u>inversión del pie</u> . Dolor brusco □ asintomático □ vuelve el dolor
SD DEL MANGUITO DE ROTADORES	Dolor subagudo del hombro que empeora por la noche: - NO duele con <u>movilidad pasiva</u> - Duele al descender activamente el bajo tras elevación de 80-120º - signo de NEER +: dolor con elevación pasiva máxima que <u>se alivia con infiltración (test NEER +)</u>
TENDINITIS CALCIFICANTE	Dolor MUY INTENSO nocturno que es autolimitado En RX (varias proyecciones): calcificación.
CAPSULITIS ADHESIVA <i>LE DUELE TODO Y LO TIENE DURO TODO</i>	Mujer de 50 años diabética que tiene rigidez en el hombro en todos los planos y limitado tanto movilidad activa como pasiva. PRUEBAS NORMALES.
SLAP (SUPERIOR LABRUM FORM ANTERIOR TO POSTERIOR)	Deportistas JÓVENES que les duele en la parte posterior y superior del hombro con CHASQUIDOS.

TENDINITIS DE QUERVAIN (<i>extensor corto y abductor largo del pulgar</i>)	Dolor y crepitación de la muñeca en zona radial que aumenta cuando desvías la muñeca a zona cubital (test de Finkelstein).
BURSITIS	Codo del estudiante: bursitis del olécranon. Rodilla de beata: bursitis prerrotuliana. Anserina/ Pata de ganso: bursitis zona medial de la tibia proximal. Dolor <u>al subir y bajar las escaleras</u> .
QUISTE DE BAKER	En ARTRITIS REUMATOIDE puede simular una tromboflebitis.
ENFERMEDAD DE DUPUYTREN	Varón blanco de 50-60 años con contractura del 5º dedo (zona cubital) con nódulos y bandas sin dolor.
ROTURA DEL TENDÓN DE AQUILES	<u>Varón que no hace mucho deporte y de repente hace una maratón (sobreesfuerzo)// inyección previa de CORTICOIDES o toma de QUINOLONAS.</u> Siente mucho dolor y nota como una patada (sino de la pedrada) NO flexión plantar Maniobra de Thompson + Hachazo en la zona.
TEMA 4	SISTEMA NERVIOSO
SD DEL TÚNEL DEL CARPO (<i>se le duermen los dedos durmiendo</i>) (nervio mediano)	Mujeres de edad media con parestesias en primer, segundo, tercer y mitad radial de los dedos sobre todo por la noche y en la mano dominante .
COMPRESIÓN DEL NERVIO CUBITAL	Mano en garra , atrofia de eminencia hipotenar (CRÓNICO). Parestesia de mitad cubital de 4º dedo y el 5º dedo (AGUDO).
SD DE WARTENBERG (nervio radial)	Afectación sensitiva del dorso de la mano y mitad proximal de 1-3 dedo y mitad radial del 4 dedo .
MERALGIA PARESTÉSICA	Embarazada/ gordo/ antecedente qx cerca de la espina iliaca que le duele la cara anterolateral del muslo tras una caminata/estar de pie mucho tiempo o sentado con flexión de cadera .
NEUROPATÍA DEL SAFENO (CANAL DE HUNTER)	Dolor cara medial del muslo distal, rodilla y pierna . RODILLA DEL SURFISTA O DEL CORREDOR.
NEUROMA DE MORTON	Mujeres de 50-60ª que tiene un dolor quemante andando y de pie entre el 3-4 dedo del pie. Se agrava con el calor y uso de calzado estrecho .

TEMA 5	TUMORES
OSTEOMA OSTEÓIDE	Adulto joven con dolor sordo e intenso, de predominio nocturno, que cede con AAS y otros AINE. Afecta fémur proximal RX: NIDUS.
TEMA 6	ORTOPEDIA INFANTIL Y ADOLESCENTE
FRACTURA SUPRACONDILAR	Niño de 6-7 años que se cae con brazo en extensión y le duele el codo. EXPLORACIÓN PULSOS Y LESIÓN N. INTERÓSEO ANTERIOR. SD COMPARTIMENTAL
TORTÍCOLIS MUSCULAR CONGÉNITA	Engrosamiento del músculo esternocleidomastoideo derecho de un recién nacido que tiene la cara girada al lado afecto (+ frec dch) y barbilla al lado contralateral.
DEFORMIDAD SPRENGEL	Elevación de una de las escápulas hipoplásicas desde el nacimiento + NO dolor + Limitación de la separación .
DEFORMIDAD DE MADELUNG	EL radio se desplaza hacia volar y cubital + dolor .
DISPLASIA DE CADERA	NIÑA recién nacida en un parto de nalgas con asimetría de pliegues de nalgas con LIMITACIÓN EN LA ABDUCCIÓN y ORTOLANI + Y BARLOW +.
ARTRITIS SÉPTICA	VARÓN recién nacido y lactante con mucho dolor en la rodilla y tiene mucha fiebre (está calentito). MEG.
SINOVITIS TRANSITORIA	VARÓN DE 8 años que ha tenido un RESFRIADO y a las semanas comienza con DOLOR UNILATERAL DE RODILLA y TODAS LAS PRUEBAS SON NORMALES. NO FIEBRE.
ENFERMEDAD DE PERTHES	VARON 3-9 AÑOS con cojera y claudicación + LIMITACIÓN EN LA ABDUCCION Y ROTACION INTERNA. MARCHA DOLOROSA Y UNILATERAL. RX: Necrosis de la cabeza femoral.
EPIFISIOLISIS	VARÓN afroamericano GORDITO CON PREADOLESCENTE CON RETRASO EN LA MADUREZ SEXUAL que tiene el miembro inferior en rotación externa con DOLOR en la CARA ANTERIOR DEL MUSLO /RODILLA y que la limitación de la rotación interna se acentúa con cuanto MÁS FLEXIONA LA CADERA.
ENFERMEDAD DE BLOUNT	Tibia vara en varón afroamericano

CONDROMALACIA ROTULIANA O DOLOR FEMORORROTULIANA DEL ADOLESCENTE	Mujer adolescente con dolor bilateral en zona anteromedial o retrorrotuliano que se da cuando sube o baja las escaleras o cuando contrae el cuádriceps (extensión).
---	--

PIE PLANO -COALICIÓN TARSAL	Paciente joven con dolor retropié , inestabilidad y esguinces frecuentes .
OSGOOD-SCHLATTER	Niño de 13 años que le duele cuando hace deporte en la <u>tuberosidad anterior de la tibia</u> .
ENFERMEDAD DE SCHEUERMANN.	Osteocondrosis que causa alteraciones de los <u>cuerpos vertebrales</u> , que provocan dolor de espalda + cifosis . Presenta: - Nódulos de Schmörl. - Alineamiento de platillos tibiales. - Acuñaamiento anterior > 5mm de 3 vértebras contiguas.
TEMA 7	CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DEL ADULTO
NECROSIS AVASCULAR DE LA CABEZA FEMORAL "PERTHES EN ADULTOS"	Varón de 20-40 años que toma alcohol , corticoides o padece Cushing con dolor insidioso de la cadera en zona inguinal, nalgas o rodilla (dolor en reposo) y con limitación de la rotación interna . Puede ser <u>bilateral</u> . RX: colapso de la cabeza femoral + radiolucencia subcondral y secuestro anterolateral.
OSTEOPOROSIS TRANSITORIA DE CADERA	Varón de 40-50 años o mujer embarazada que comienza de manera súbita con dolor en UNA cadera cuando ANDA . RX: osteopenia.

UROLOGÍA

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 2	INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
PROSTATODINIA	Hombre estresado que simula una prostatitis (le duele) pero todo es negativo (urocultivo negativo y en líquido prostático < 10 leuco/campo).
TUBERCULOSIS GENITOURINARIA	Varón < 50 años + piuria ácida estéril con urocultivo negativo . Cultivo de lowenstein (+) . Urograma: estenosis unión ureterovesical + mordiscos caliciales (riñón mastic en fase final).
CISTITIS INTERSTICIAL	Mujer de 70 años que tiene un cuadro cístico crónico con TODAS LAS PRUEBAS NEGATIVAS y: - <u>Cistoscopia</u>: petequias submucosas al distender la vejiga. Y úlceras de HUNNER. - <u>Biopsia</u>: mastocitos.
PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA	Mujer con infección renal CRÓNICA que puede tener una masa palpable (debido a <u>dilataciones caliciales y litiasis</u>) <u>AP</u> : macrófagos espumosos .
TEMA 3	UROLITIASIS
CÓLICO RENAL	varón de 30 años con Dolor lumbar unilateral que irradia a genital que NO Cambia con la postura y se acompaña de cortejo vegetativo (náuseas, vómitos).
UROLITIASIS INFECTIVAS (ESTRUVITA)	Mujer con ITU de repetición con dolor lumbar sordo + hematuria p IR (litiasis coraliforme).
TEMA 4	TUMORES RENALES
CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES. HIPERNEFROMA. TUMOR DEL INTERNISTA	Varón 40-60 años obeso y fumador con triada : hematuria + dolor + masa en flanco (TRIADA CLÁSICA) Varón 40-60 años con hematuria + cuadro constitucional Varicocele izquierdo que no cede en decúbito.

SD STAUFFER	El paciente tiene un tumor primario y <u>elevación de enzimas hepáticas sin existir realmente una metástasis</u> . Relacionado con ca células renales .
TUMOR DE GRAWITZ	Hipernefroma, adenocarcinoma renal o carcinoma renal de células claras.

TEMA 5	HBP Y Ca de PROSTATA
HBP	Varón >80 años: +: - Clínica <u>obstructiva</u> retraso de la micción, menor chorro y menos fuerza y alargamiento del vaciado. - Clínica <u>irritativa</u>: tenesmo, polaquiuria, nicturia, y urgencia miccional. Incontinencia por rebosamiento.
TEMA 6	CARCINOMA DEL TRACTO URINARIO
Carcinoma de vejiga	<u>Persona fumadora</u> o que tiene una infección por <u>schistosoma haematobium</u> + hematuria macroscópica o microscópica mono sintomática. Sospechar: <u>Ca in situ vesical</u>: SD miccional crónico con urocultivo negativo. <u>Tumor sólido vesical</u>: síntomas obstructivos (dolor en flancos, edemas o dolor pélvico).
TEMA 7	TUMOR TESTICULAR
LINFOMA	Masa testicular > 50 años.
TUMOR TESTICULAR	Masa escrotal indolora, sin signos inflamatorios y con largo periodo de evolución.
CORIOCARCINOMA	Paciente joven con masa escrotal indolora sin signos inflamatorios y largo periodo de evolución con sintomatología pulmonar (RX en suelta de globos) y (aumento de BHCG).

REUMATOLOGÍA

	Asociaciones clínicas
ANA: LES (98%) , lupus inducido (100%), EMTC (95-100%), esclerosis sistémica (70-95%), síndrome de Sjögren (70-90%)	
Anti-ADN ss	LES, otras enfermedades del tejido conjuntivo, inespecífico
Anti-ADN ds	LES (70%) específico. Se correlaciona con la actividad de la enfermedad y se asocia a lupus grave (nefritis, SNC)
Anti-Sm	LES (30%). El más específico del LES
Antihistona	LES inducido, pero también en LES espontáneo
Anti-Ro (SS-A)	Síndrome de Sjögren primario (60-70%), LES (30%), lupus neonatal, LCSA. Menor riesgo de nefritis
Anti-La (SS-B)	Síndrome de Sjögren primario (50-60%), LES (10-15%) Bajo riesgo de nefritis
Anti-Scl-70	ESC difusa (70%), ESC limitada (15%), afectación intersticial pulmonar
Anticentrómero	ESC limitada (75%), ESC difusa (15%), hipertensión pulmonar
Anti-RNP	EMTC (100%), LES (30-50%)
Anti-Jo1	Síndrome antisintetasa (miopatía, enfermedad pulmonar intersticial y manos de mecánico)

Tabla 1.3. Anticuerpos antinucleares y asociaciones clínicas (ESC: esclerodermia; EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo; LCSA: lupus cutáneo subagudo)

ENFERMEDAD	CUADRO CLÍNICO TÍPICO
TEMA 2	ENF METABÓLICA OSEA
OSTEONECROSIS MAXILAR/ MANDIBULAR SUPER PREGUNTADO	Mujer con afectación mandibular (exposición ósea de la mandíbula) EXPOSICIÓN DEL HUESO NECRÓTICO MAXILAR/MANDIBULAR + con toma de bifosfonatos /denosumab durante un tiempo prolongado.
ENFERMEDAD DE PAGET	Crecimiento óseo (cabeza) + aumento de FA.
OSTEOMALACIA	Resección intestinal /cirugía bariátrica/ abueloma (poca exposición al sol + líneas de LOOSER MILKMAN.
TEMA 3	ARTRITIS REUMATOIDE
SD DE CAPLAN	AR con nódulos pulmonares + neumoconiosis. Patrón reticular y en panal de abeja con aumento de densidad en ambos lóbulos inferiores

AMILOIDOSIS	AR y sd. nefrótico/proteinuria.
-------------	--

SD DE FELTY	Neutropenia (leucopenia) + esplenomegalia + AR.
ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL, FORMA SISTÉMICA	Niño < 5 años con fiebre + rash no pruriginoso que coincide con la fiebre + artralgiás /artritis. FR y ANA negativos.
ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL OLIGOARTICULAR	Niñas < 6 años con ANA + Uveítis anterior aguda Artritis de grandes articulaciones respetando la cadera
ENFERMEDAD STILL DEL ADULTO	Mujeres jóvenes con fiebre + rash + artritis Altos valores de ferritina.
TEMA 4	ESPONDILOARTROPATÍAS
SD DE REITER	Artritis reactiva + uretritis + conjuntivitis.
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	Varón joven con dolor lumbar inflamatorio.
ARTRITIS PSORIASIS	Psoriasis + poliartritis simétrica que afecta a mano (IFD)+ afectación de uñas FR, ACC, FR negativos.
ARTRITIS REACTIVA	Ap: infección urogenital / digestiva. Conjuntivitis y dactilitis con artritis. Suele tener talalgia.
ENFERMEDAD DE FORESTIER O HIPEROSTOSIS ANQUILOSANTE VERTEBRAL DIFUSA	HLA B27 –. NO SACROILEÍTIS. CALCIFICACIÓN DEL LIGAMENTO VERTEBRAL ANTERIOR + PUENTES ÓSEOS INTERVERTEBRALES GRUESOS.
ARTRITIS ASOCIADA A LA EEII	Paciente joven con enfermedad digestiva / clínica digestiva que presenta artritis (periférica /axial).
SD DE SAPHO	Sinovitis + acné + pustulosis + hiperostosis + osteítis
TEMA 5	ENFERMEDAD POR MICROCRISTALES
SD DE LESCH-NYHAN	Déficit completo de HGPRT: hiperuricemia, hiperaciduria, cálculos de urato + coreoatetosis y trastornos neurológicos.
SD DE KELLEY SEEGMILLER	Déficit parcial de HGPRT: gota y cálculos renales.
HOMBRO DE MILWAUKEE	Mujeres >60 años, depósito de hidroxipatita en el manguito de los rotadores. Gran inestabilidad.
TEMA 6	INFECCIÓN ARTICULAR

INFECCIÓN POR BRUCELLA	Veterinario (contacto con animales) con fiebre alta (de 39) y afectación articular (rodilla)/ espondilodiscitis lumbar + dolor testicular (orquitis/epididimitis). Rosa de bengala. HC max rentabilidad (7-21 días). Tto: doxiciclina + estreptomicina +/- gentamicina/rifampicina
------------------------	--

TEMA 8	VASCULITIS
ARTERITIS DE LA TEMPORAL	Mujeres caucásicas con polimialgia reumática (dolor en la cintura pélvica/ hombros) con cefalea unilateral y pulsátil que no responde al tto + amaurosis fugax + claudicación mandibular Biopsia: granulomas/ no necrotizante/ parcheada. ECO: signo del halo EF: Palpación de la arteria temporal derecha con ausencia de pulso. Analítica: aumento de VSG.
PAN	Necrotizante sin granulomas Dolor abdominal + HTA + dolor de testes + microaneurismas en bifurcación.
PAM	HTA + DOLOR ABDOMINAL + HEMORRAGIA ALVEOLAR /HEMOPTISIS + GMN
WEGENER	ORL + infiltrados pulmonares CAVITADOS NO MIGRATORIOS + C-anca
CHURG STRAUSS	ASMA difícil control + eosinofilia e infiltrados pulmonares MIGRATORIOS NO CAVITADOS.
PÚRPURA DE SCHOLEIN HENOCCH	Niño de 15 años con infección respiratoria previa que empieza con púrpura palpable en MMII respeta abdomen + artralgias + dolor abdominal + edema escrotal + GMN AS: leucocitosis / plaquetas normales / aumento IgA.
ENFERMEDAD DE BUERGER	Varón joven fumador con isquemia en los dedos. no afectación visceral.
ERITEMA ELEVATUM DIUTINUM	Placas y pápulas en zonas de extensión (ej. Rodilla) + vasculitis leucocitoclástica (PMN en la pared)
VASCULITIS CRIOGLOBULINÉMICA	- Púrpura palpable + Artralgias o artritis + Astenia.
TEMA 9	LUPUS
SD DE EVANS	Anemia hemolítica autoinmune + trombopenia. Muy característico del LES (pero se puede ver en otros, como la LLC).
OSTEONECROSIS ASEPTIVA O NECROSIS AVASCULAR	Mujer con lupus y dolor mecánico intenso y limitante En hombro, rodilla, cadera. Hacer una RM Mucho tiempo con corticoides. NO SE HACE ARTROCENTESIS.

TEMA 10	ESCLEROSIS SISTÉMICA
ESCLERODERMIA DIFUSA	Clínica: - Insuficiencia renal rápidamente progresiva. - Hipertensión maligna con encefalopatía y retinopatía hipertensiva. - Acompañada a veces de anemia hemolítica microangiopática.
TEMA 11	AMILOIDOSIS
AMILOIDOSIS SECUNDARIA (AA)	Enfermedad infecciosa/ inflamatoria crónica que empieza con un sd nefrótico (AMILOIDOSIS AA) Rojo Congo + y birrefringencia en verde manzana SD NEFRÓTICO + ARTRITIS REUMATOIDE

FIEBRE MEDITERRANEA FAMILIAR	- Fiebre: en casi todos los pacientes, de forma brusca, hasta 39-40°C. - Manifestaciones digestivas (91%): secundarias a peritonitis aséptica que puede manifestarse como abdomen agudo. - Dolor torácico (50%): por pleuritis o pericarditis estéril. - Manifestaciones articulares: secundarias a sinovitis estéril, se manifiestan como artralgias o artritis. - Manifestaciones cutáneas: muy diversas, más típica el eritema erisipeloides en parte anterior de la pierna y dorso del pie.
TEMA 12	SJÖGREN
LINFOMA NO HODGKIN DE CÉLULAS B MALT / linfoma difuso de células grandes	Mujer con sjogren con tumefacción parotídea persistente /adenopatías hiliares o mediastínicas / nódulos pulmonares o adenopatías periféricas. Analítica: - Negativiza el FR, linfopenia, consumo del complemento (C4). - Aumento de hipergammaglobulinemia , B2 microglobulina, LDH.
TEMA 13	MIOSITIS
SD ANTISINTETASA “Jo, vaya con MAFPre”	ANTI JO-1 Manos de mecánico Miositis Artritis no erosiva Fibrosis pulmonar Raynaud.
DERMATOMIOSITIS AMIOPÁTICA	CLÍNICA TÍPICA - Exantema palmar intenso. - Úlceras digitales. - Enfermedad pulmonar intersticial de progresión rápida.
TEMA 14	OTRAS
ENFERMEDAD POR IG-G4	Varón mediana edad/edad avanzada con cuadro constitucional que cursa con: - Aortitis/ fibrosis retroperitoneal/asma/alergia/pancreatitis autoinmune/linfadenopatía/sialoadenitis submandibular - Densa infiltración de células plasmáticas ricas en IgG4. - Patrón de fibrosis denominado estoriforme. - Flebitis obliterante. - Concentración sérica elevada de IgG4.
SD MAGIC	Policondritis recidivante + sd behcet (úlceras orales y genitales)

MIR
ENFURECIDO

LAURA
FRÍAS